Serie de documentos técnicos en el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar del departamento de Boyacá

Pautas de cuidado basadas en la evidencia para el abordaje del riesgo cardiovascular en la familia en el entorno hogar.

Gobernación de Boyacá | Salud

Gloria Yaneth Manrique Abril

Secretaria de salud

Candy Samanta Rodríguez Castillo

Directora de Promoción y Prevención

Martín Orlando Barrera Cobos

Profesional Universitario

Secretaría de Salud de Boyacá

Blanca Nubia Vásquez

Profesional Universitario

Secretaría de Salud de Boyacá

Grupo Desarrollador

Lorena Mesa Melgarejo

Enfermera, Magister en Salud Pública, Máster en Economía de la Salud y Doctora en Salud Pública. Secretaria de Salud de Boyacá

Oscar Andrés Virgüez Ramos

Médico familiar. Coordinador académico de la Especialización en Medicina Familiar y docente de la Escuela de Medicina, UPTC.

Nora Edith Rodríguez Puerto

Médica familiar. Docente de la Especialización en Medicina Familiar, UPTC.

Expertas y expertos participantes

Karen Tatiana Gamba Malagón.

Médica familiar. Profesional de apoyo del Programa de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Secretaria de Salud de Boyacá.

Lina Arias Celis.

Médica funcional. Profesional de apoyo del Programa de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Secretaria de Salud de Boyacá.

Erika Fernanda Sarmiento Matta.

Enfermera profesional. Profesional de apoyo del Programa de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Secretaria de Salud de Boyacá.

Declaración de conflictos de intereses:

Las personas que participaron en la elaboración, revisión y validación de las presentes Pautas de cuidado basadas en la evidencia fueron invitadas a declarar sus intereses financieros, profesionales, académicos, institucionales y personales que pudieran influir, o percibirse como susceptibles de influir, en el desarrollo de los contenidos y la formulación de las recomendaciones. No se identificaron conflictos de intereses que comprometieran la independencia técnica del proceso de elaboración de este documento.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial:

La herramienta Claude de Anthropic fue utilizada en el presente documento para el proceso de extracción de datos de los textos completos seleccionados en las matrices de síntesis de la información. Su utilización fue complementaria al trabajo del equipo responsable y no sustituyó los procedimientos de búsqueda, selección, análisis crítico e interpretación de la evidencia científica, ni los procesos de deliberación y formulación de las pautas de cuidado. La responsabilidad por la rigurosidad metodológica, la pertinencia de las recomendaciones, la integridad de la información y el contenido final del documento corresponde exclusivamente al equipo humano responsable de su elaboración.

Contenido

1. Introducción 7
2. Objetivos 8
2.1 General 8
2.2 Específicos 8
3. Alcance 9
Población objetivo 9
Usuarios 9
Contexto 9
Aspectos abordados 9
Aspectos no abordados 9
4. Contexto territorial de la condición de salud 10
4.1 Riesgo cardiovascular: desde un enfoque familiar 12
5. Marco normativo 13
6. Preguntas orientadoras 14
7. Metodología ..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.1 Priorización de temas ..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.2 Construcción y validación del alcance y preguntas orientadoras. **¡Error! Marcador no definido.**
7.3 Búsqueda y selección de la evidencia. **¡Error! Marcador no definido.**
7.4 Síntesis de evidencia y formulación de pautas basadas en evidencia. 17
7.5 Consenso informal, adaptación al contexto y reglas de decisión. 17
8. Resultados: Síntesis narrativa de la evidencia. 17
8.1 Pregunta 1. 17
8.2 Pregunta 2. 21
8.3 Pregunta 3. 23
8.4 Pregunta 4. 28
9. Pautas de cuidado basadas en la evidencia para el abordaje del riesgo cardiovascular en la familia. 35
9.1 Pautas generales 35

9.2 Pautas pregunta 1. Establecimiento del riesgo cardiovascular. 36
9.3 Pautas pregunta 2. Intervenciones 40
9.4 Pautas pregunta 3. Escalamiento y coordinación.....44
9.5 Pautas pregunta 4. Intervenciones para adherencia 47
10. Referencias 51
11. Anexos 58
11.1 Ecuaciones de búsqueda.....58

1. Introducción

En Boyacá, las enfermedades cardiovasculares y sus principales factores de riesgo se comportan como un problema prioritario de salud pública y un reto para su abordaje desde el modelo de atención planteado en el departamento. El ASIS 2023 muestra que, en 2022, la mortalidad prematura por ECNT (30–70 años) fue de 217,1 por 100.000, y que las enfermedades cardio-cerebro-vasculares constituyeron la primera causa de muerte con 101,7 por 100.000, incluso por encima del promedio nacional para este componente (1) . Esta carga se acompaña de brechas relevantes en control de riesgos clínicamente modificables, por ejemplo para 2022 se reportaron 78.265 personas con hipertensión y solo 66,05% con cifras controladas; en diabetes, aunque se habían diagnosticado 25.127 personas, apenas 43,28% tuvo medición reciente de HbA1c y, entre quienes se midieron, 53,33% alcanzó metas de control (2) . En conjunto, estos datos sugieren espacio para fortalecer la detección oportuna, la estratificación del riesgo y el seguimiento efectivo, especialmente antes de que ocurran eventos cardiovasculares mayores.

La respuesta requiere considerar el territorio y el modo real de acceso, al respecto es importante considerar que Boyacá tiene una ruralidad extensa, dónde el 39,47% de la población vive en centros poblados y área rural dispersa, con variaciones importantes entre municipios. En estas condiciones, la continuidad del cuidado suele verse afectada por barreras geográficas y logísticas, lo cual aumenta la probabilidad de diagnósticos tardíos, discontinuidad terapéutica y seguimiento incompleto. Por tanto, la visita a la familia se convierte en un escenario de alto valor para identificar riesgos no detectado (incluyendo cohabitantes), reconocer barreras concretas del hogar (adherencia, hábitos, acceso a medicamentos y controles) y activar rutas de manejo y remisión con criterios homogéneos.

En este marco, orientaciones basadas en evidencia para la "familia con integrante(s) que requiere(n) detección temprana y manejo integral del riesgo cardiovascular familiar en el entorno hogar" se justifica como instrumento de estandarización de la práctica para el Plan Integral de Cuidado Familiar (PICF), al reducir la variabilidad en la forma de evaluar riesgo, priorizar familias y orientar decisiones clínicas y de salud pública. El propio lineamiento técnico del PICF define que, durante las visitas de seguimiento, se debe actualizar y evaluar el riesgo familiar, acompañar compromisos de cuidado y fortalecer la agencia de cuidado mediante procesos de información y educación, con registro sistemático en los

instrumentos del programa(3)). Así, este documento busca traducir la carga de enfermedad y las condiciones territoriales de Boyacá en un estándar operativo claro que facilite qué medir, cómo estratificar, cuándo intervenir y cuándo remitir, poniendo al hogar y a la familia como unidad efectiva de intervención para prevenir eventos y mejorar resultados en salud.

En este contexto, es importante mencionar que en este documento de apoyo a la práctica profesional, el enfoque familiar para abordar el riesgo cardiovascular en el entorno hogar se entiende como una forma de atención que reconoce a la familia y el hogar como unidad de evaluación e intervención, y no solo a la persona "caso índice", dado que el riesgo cardiovascular se construye y modifica por hábitos compartidos, un entorno común (alimentación, actividad física, exposición a tabaco, condiciones de vivienda), y por la interdependencia de roles, apoyos y tensiones que influyen en el autocuidado y la adherencia. En consecuencia, el equipo de salud establece una alianza corresponsable con la persona y su familia para identificar activamente riesgos en cohabitantes, valorar factores clínicos y contextuales del hogar, acordar metas realistas de cambio conductual y cuidado, y asegurar seguimiento y articulación con la red de servicios. Así, el enfoque familiar permite traducir la detección temprana y la estratificación del riesgo en acciones sostenibles dentro de la vida cotidiana, fortaleciendo la capacidad del hogar para prevenir complicaciones y mejorar resultados cardiovasculares.

2. Objetivos

2.1 General

Identificar pautas de cuidado, con base en evidencia, para que el equipo de salud durante la visita familiar identifique, estratifique y acompañe el logro de los compromisos de la familia relacionados con abordaje al riesgo cardiovascular.

2.2 Específicos

- ✓ Definir y estandarizar, desde un enfoque familiar y sistémico, los criterios, estrategias e instrumentos para identificar y estratificar el riesgo cardiovascular en el núcleo familiar durante la visita en el

marco del PICF, incluyendo la búsqueda activa de riesgo en cohabitantes.

- ✓ Definir intervenciones basadas en evidencia para modificar prácticas cotidianas del hogar (alimentación, actividad, tabaco/alcohol, adherencia) y fortalecer agencia de cuidado y apoyo entre cohabitantes.
- ✓ Precisar los criterios de alarma y activación de rutas desde el entorno hogar y el nivel primario, para prevenir eventos cardiovasculares mayores y favorecer el cuidado y atención integral.
- ✓ Proponer con base en la evidencia disponible un esquema de acompañamiento a los logros de la familia en el tema de riesgos cardiovasculares.

3. Alcance

Población objetivo

Familias con riesgo cardiovascular identificado por medio de instrumentos de tamización usados durante la caracterización de la familia.

Usuarios

Equipos básicos e interprofesionales de salud que realizan plan de cuidado familiar.

Contexto

Implementación en entorno hogar mediante visitas PICF, con énfasis en tamizaje/identificación de riesgo, educación dialógica, intervención breve, seguimiento y activación de rutas.

Aspectos abordados

- Estratificación de riesgo a nivel familiar, identificación de "casos índice" y búsqueda activa de riesgo en cohabitantes.
- Plan de cuidado familiar: metas de autocuidado, adherencia, actividad física, alimentación, consumo de tabaco/alcohol.
- Signos de alarma cardiovasculares y criterios de remisión.
- Seguimiento en el entorno hogar y verificación de acceso efectivo a controles/medicamentos.

Aspectos no abordados

- Manejo especializado intrahospitalario o de alta complejidad (síndromes coronarios agudos, IC descompensada, etc.), ni reemplazo de la normativa o RIAS vigentes

4. Contexto territorial de la condición de salud

En Boyacá, el riesgo cardiovascular familiar se configura como un problema prioritario por su carga poblacional y por las brechas en control de factores modificables. El ASIS 2023 reporta que en 2022 la mortalidad prematura por ECNT (30–70 años) fue de 217,1 por 100.000 y que las enfermedades cardio-cerebrovasculares fueron la primera causa con 101,7 por 100.000, como ha sido mencionado en secciones anteriores. Este patrón se acompaña de indicadores de gestión que sugieren oportunidades de mejora: para 2022 se registraron 78.265 personas con hipertensión y 66,05% con control tensional, mientras que en diabetes, de 25.127 diagnosticadas, solo 43,28% tuvo medición reciente de HbA1c y, entre quienes se midieron, 53,33% alcanzó la meta de control(1). En conjunto, la evidencia departamental apunta a un riesgo cardiovascular con impacto temprano (prematuro) y con ventanas claras para detección oportuna y seguimiento, especialmente si se trabaja con el hogar como unidad de intervención.

En el marco de barreras de acceso por casusas en su mayoría geográficas en el departamento, el riesgo cardiovascular se vuelve también un problema de continuidad, dónde la oportunidad de controles, el acceso a servicios y el seguimiento sostenido se ven condicionados por distancias, tiempos de desplazamiento y barreras logísticas, justifica estandarizar acciones de tamizaje, estratificación y remisión en el entorno hogar.

Adicionalmente, los reportes del sistema de información del PICF (SIBACOM) aportan evidencia clave para "aterrizar" el problema a la operación real del PICF. El Índice Compuesto de Riesgo Familiar (ICRF), calculado con la ficha de caracterización, integra dimensiones como vivienda, saneamiento, salud, seguridad alimentaria, factores psicosociales y curso de vida; en junio el promedio osciló entre 23 y 43 (Subred 2 como la más crítica con 43), y en julio entre 18 y 33 (Subred 5 con el mayor riesgo, 33), confirmando la necesidad de priorización diferencial por subred (3) . En este mismo informe, se reporta que el componente de vulnerabilidad material reflejado en Necesidades Básicas Insatisfechas, las subredes 10, 5 y 9 registraron los mayores porcentajes de pobreza y miseria (15,5%, 14,5% y 13,1%). Además, la funcionalidad familiar (APGAR) muestra una carga alta de disfuncionalidad en subredes

con mayor vulnerabilidad, con valores como 64,79% (Subred 10) y 58,16% (Subred 2) en junio, lo cual es clínicamente relevante porque condiciona adherencia, cambios conductuales y sostenibilidad del cuidado.

En la misma línea, el SIBACOM identifica señales directas de complejidad, por ejemplo, presencia de enfermedades crónicas sin control que llega al 17% en Subred 1; todo ello sustenta que el riesgo cardiovascular en Boyacá no es solo "biológico", sino familiar, social y territorialmente determinado, lo que hace pertinente un lineamiento centrado en el entorno hogar.

Desde el punto de vista clínico-operativo, SIBACOM muestra capacidad de movilización de oferta institucional mediante "demanda inducida" en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, al respecto se muestra que en julio, la Subred 2 pasó de 9.817 procedimientos en junio a 15.809 en julio, seguida por Subred 5 (6.524), Subred 4 (5.330) y Subred 7 (4.429)(3). Sin embargo, el propio reporte advierte limitaciones de registro: subredes como la 1 no reportan procedimientos y se sugiere que algunos equipos no diligencian el botón de atenciones individuales, lo que implica posibles subregistros.

En paralelo, el contexto internacional subraya la magnitud del problema: la OMS estima que en 2022 murieron 19,8 millones de personas por enfermedades cardiovasculares (≈32% de todas las muertes), con 85% asociadas a infarto y accidente cerebrovascular. Este marco global, junto con la normativa nacional que orienta acciones de promoción/mantenimiento y gestión del riesgo(4), refuerza la pertinencia de estandarizar tamizaje, estratificación y rutas de manejo a nivel familiar.

No obstante, persisten vacíos de información que conviene declarar explícitamente para estudios posteriores y para el fortalecimiento del sistema de monitoreo del lineamiento. Primero, aunque los reportes SIBACOM evidencian la dinámica de demanda inducida y permiten priorización por riesgo familiar (ICRF), no dejan visible de forma consistente el conteo específico de "tamizajes de riesgo cardiovascular" (por curso de vida, subred, sexo, ruralidad) ni su rendimiento (positividad, proporción de alto riesgo, remisiones efectivas), lo que limita cuantificar cobertura y brechas del tamizaje cardiovascular en entorno hogar. Segundo, la posible variabilidad en el diligenciamiento (subregistro) sugiere la necesidad de auditorías de calidad de dato y estandarización del registro. Tercero, haría falta integrar (o triangular) SIBACOM con otras fuentes (p. ej., CAC/aseguramiento, RIAS, SISPRO) para estimar el "riesgo no diagnosticado" o la continuidad real de control (medicación/controles) y desenlaces evitables (urgencias,

hospitalizaciones), de modo que el lineamiento pueda monitorear impacto más allá de actividad realizada y se traduzca en reducción de eventos cardiovasculares y de mortalidad prematura(1,3).

4.1 Riesgo cardiovascular: desde un enfoque familiar

El riesgo cardiovascular se refiere a la probabilidad de que una persona experimente un evento cardiovascular (por ejemplo, infarto o accidente cerebrovascular, fatal o no fatal) en un horizonte de tiempo definido, con frecuencia a 10 años. La OMS lo describe en términos de predicción de riesgo, dónde "identificar individuos según la probabilidad de presentar un evento cardiovascular futuro, y resalta que dicho riesgo resulta de la combinación de factores conductuales (tabaquismo, dieta no saludable, inactividad física, alcohol) y fisiológicos/metabólicos (presión arterial elevada, hiperglucemia, colesterol elevado), a su vez influenciados por determinantes sociales"(5).

Cuando este concepto se traslada a la familia, el riesgo cardiovascular se entiende como un fenómeno sistémico, es decir no es solo la suma de riesgos individuales, sino el resultado de una interdependencia entre miembros y un entorno compartido que condiciona exposiciones y comportamientos (qué se compra y cocina, cómo se organiza el tiempo para actividad física, normas sobre tabaco/alcohol, patrones de sueño/estrés, y acceso a servicios). La evidencia muestra que los factores de riesgo mayores tienden a "acomodarse" dentro del hogar: una revisión sistemática y metaanálisis encontró concordancia conyugal significativa para hipertensión, tabaquismo, diabetes y obesidad, con odds ratios globales aproximadamente entre 1,16 y 3,25, lo que sugiere que convivir (y construir rutinas compartidas) se asocia con perfiles de riesgo semejantes(6).

Además, estudios poblacionales han mostrado que el agrupamiento (clustering) de factores de riesgo cardiometabólico suele ser más alto a nivel de hogar que a niveles comunitarios o distritales: en análisis con encuestas nacionales en India, el nivel de clustering fue generalmente mayor en hogares (excepto para tabaquismo), por encima de comunidades, distritos y (7). Este tipo de hallazgos apoya una lectura epidemiológica útil para el "entorno hogar", dado que el hogar funciona como un microambiente donde se concentra riesgo (presión arterial, glucosa, exceso de peso) y donde, por tanto, intervenciones y tamizajes pueden ser más eficientes si se diseñan para el grupo familiar y no únicamente para el individuo.

Finalmente, comprender el riesgo cardiovascular en la familia también implica incorporar la dimensión intergeneracional y de historia familiar. Las guías clínicas de prevención primaria reconocen que la historia familiar de ASCVD prematura es un elemento relevante en la discusión de riesgo y puede actuar como "factor que intensifica" la toma de decisiones preventivas, junto con otros marcadores clínicos y metabólicos(8). En términos prácticos, esto significa que una lectura familiar del riesgo cardiovascular combina: (i) medición y estratificación del riesgo individual, (ii) evaluación del hogar como entorno que produce o reduce riesgo, y (iii) identificación de patrones y antecedentes familiares que justifican búsqueda activa de riesgo en cohabitantes y acuerdos familiares para cambios sostenibles.

5. Marco normativo

El desarrollo del presente documento tiene en consideración el marco normativo nacional y territorial vigente y en particular las siguientes normas aplicables:

Tabla 1. Marco normativo aplicable

Norma	Aspecto
Ordenanza del departamento de Boyacá	Establece el Modelo de Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque familiar como política pública en el departamento de Boyacá
Ley 1438 de 2011	Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
Ley 1751 de 2015	Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.
Resolución 3280 de 2018	Lineamientos técnicos y operativos de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y Ruta Materno Perinatal, y directrices para su operación.
Ley 2297 de 2023	Medidas en beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y los cuidadores/as o asistentes personales, y otras disposiciones.
Resolución 1597 de 2025	Disposiciones para la gestión territorial integral de la salud pública incluida la Gestión en Salud Pública y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), en el marco del Plan Decenal de Salud Pública y la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS).

Fuente: elaboración propia

6. Preguntas orientadoras

- En adultos atendidos en el hogar o en atención primaria/comunitaria, ¿qué escalas o herramientas de riesgo cardiovascular muestran mejor desempeño y factibilidad para clasificar el riesgo y orientar decisiones de cuidado?
- En personas adultas y familias con riesgo cardiovascular abordadas en el entorno hogar, ¿qué intervenciones familiares o domiciliarias son efectivas y factibles para reducir el riesgo cardiovascular y controlar sus factores de riesgo, y cómo deben priorizarse según el nivel de riesgo cardiovascular?
- En personas adultas con riesgo cardiovascular y sus familias, atendidas en el hogar, ¿qué signos, síntomas y hallazgos clínicos deben considerarse señales de alarma para activar la atención urgente, la remisión o la referencia, y cómo debe orientarse la respuesta según el evento sospechado y el nivel de atención disponible?
- ¿Qué estrategias en el entorno hogar deben recomendarse para favorecer la adherencia farmacológica en personas adultas con riesgo cardiovascular y sus familias?

7. Metodología

El desarrollo de esta herramienta se basa en el Manual para el desarrollo de lineamientos técnicos basados en evidencia del IETS (primera edición, 2024) y en el objetivo de consolidar y difundir acciones/indicaciones basadas en la mejor evidencia disponible e integrando experiencia experta y contexto territorial. Así, la metodología se organizó en cuatro momentos: 1. Priorización de temáticas; 2. validación de preguntas con equipo AT-PIC y referentes; 3. búsqueda y selección sistemática de evidencia y síntesis, y 4. construcción de pautas/lineamientos con consenso informal.

7.1 Priorización de temas

El proceso de priorización de temáticas para desarrollar cinco herramientas basadas en evidencia en el marco del PICF inició con una identificación preliminar de problemáticas mediante triangulación de fuentes (seguimiento PICF, cruce con núcleos/respuestas del Plan

Territorial de Salud y ASIS), delimitando desde el inicio temas con alta posibilidad de intervención directa por los equipos básicos (acciones clínicas, seguimiento familiar, educación, detección temprana y articulación con RIAS) y excluyendo determinantes estructurales cuyo abordaje principal no es sanitario. Posteriormente, se aplicó una priorización multicriterio con cinco criterios explícitos (magnitud, severidad, inequidad, factibilidad y alineación), con ponderaciones sugeridas (25%, 20%, 20%, 25% y 10%, respectivamente) y un esquema de votación 1–5 con reglas de inclusión/exclusión por acuerdo ≥80%, utilizando una técnica tipo Delphi con calificación ciega por expertas/os.

La priorización se realizó en dos rondas con dos grupos: primero el equipo de Asistencia Técnica del PIC (ronda 1) y luego el equipo de Promoción y Prevención (ronda 2), incorporando además temáticas nuevas sugeridas al final del cuestionario para ser consideradas en la segunda ronda. Finalmente, tras comparar resultados de la segunda ronda, se definieron las cinco temáticas seleccionadas para la vigencia: (i) riesgo cardiovascular familiar, (ii) consumo de riesgo y problemático de alcohol, (iii) salud del cuidador en hogares con dependencia/cronicidad, (iv) valoración y cuidado integral de la persona mayor (vejez) y (v) cuidados en el hogar para familias con recién nacidos y mujeres en posparto.

7.2 Construcción y validación del alcance y preguntas orientadoras.

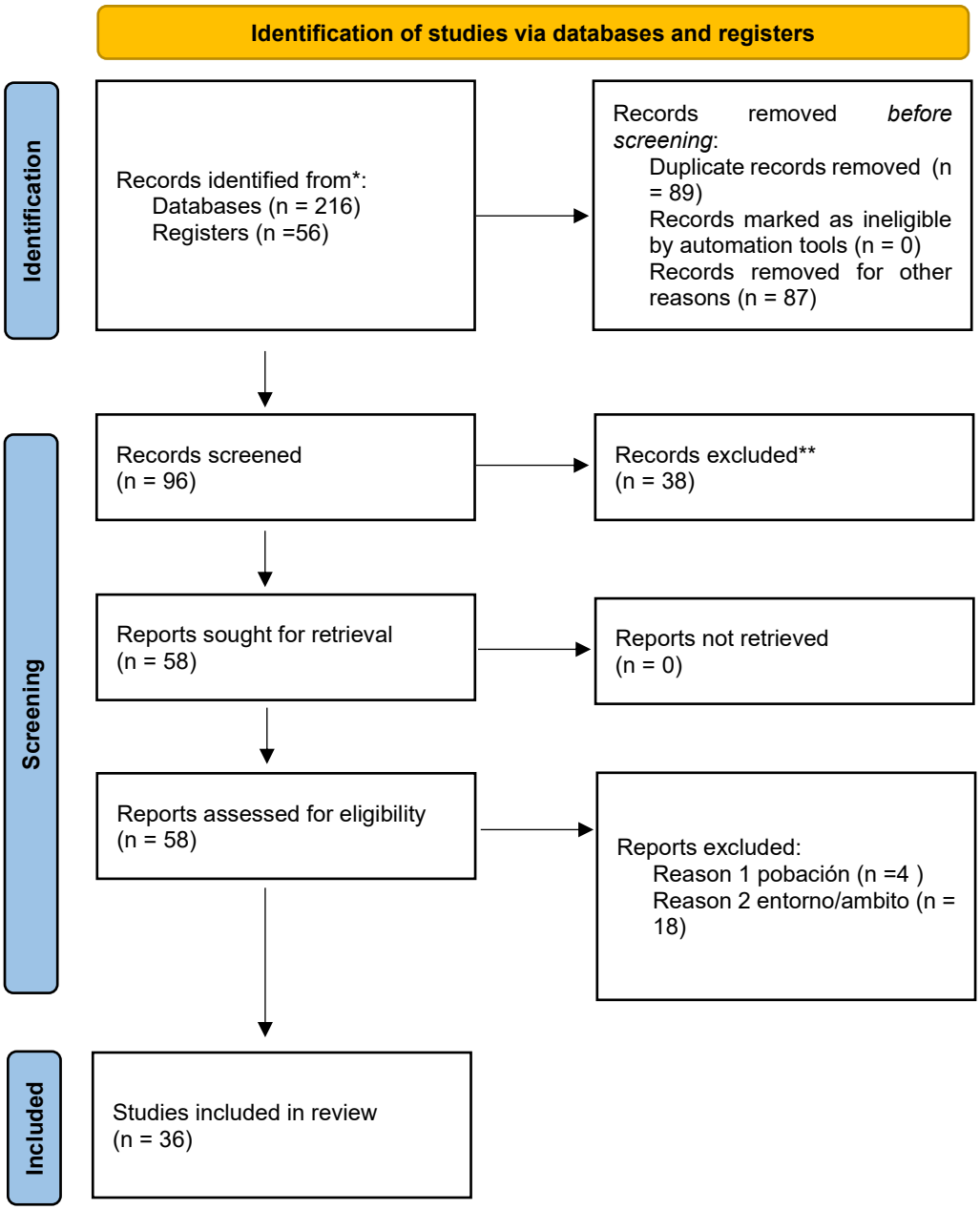
A partir de la triangulación de fuentes sobre los aspectos epidemiológicos, clínicos y de interacción con algunos equipos de salud, se construyeron las preguntas orientadoras, las cuales se socializaron y validaron con el equipo y referentes por medio de sesiones deliberativas. Este proceso sigue el modelo de lineamientos que contempla reuniones para discutir, ajustar y consensuar alcance y preguntas.

7.3 Búsqueda y selección de la evidencia.

Para responder a cada pregunta, se realizó una búsqueda sistemática estructurando ecuaciones de búsqueda a partir de términos indexados entre marzo y junio de 2026. Se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos: MEDLINE, Cochrane y LILACS, complementada con literatura gris mediante Google Académico.

La estrategia incluyó (i) una búsqueda para identificar Guías de Práctica Clínica (GPC) recientes y (ii) una búsqueda para identificar revisiones sistemáticas, con búsquedas independientes por pregunta cuando fue necesario. Los criterios de inclusión fueron: evidencia aplicable al entorno hogar, acorde con la población objeto, revisiones sistemáticas de literatura, guías de práctica clínica, consensos basados en la evidencia, publicaciones en inglés o español, sin límite de año. Las RSL se verificaron con la lista de chequeo AMSTAR; AGREE para el caso de las GPC, y ACCORD para el caso de los consensos.

El siguiente es el PRISMA de la revisión realizada:



7.1 Síntesis de evidencia y formulación de pautas basadas en evidencia.

La evidencia incluida se resumió en aspectos clave para las intervenciones recomendadas en el entorno hogar para cada pregunta (beneficios/daños, desempeño de instrumentos de estratificación, factibilidad, recursos, equidad, aceptabilidad), privilegiando la síntesis de narrativa de la evidencia. Con base en esto y en la experiencia del equipo clínico y territorial, se elaboraron pautas preliminares que posteriormente se sometieron a discusión y consenso por parte del grupo de referentes de la secretaria de salud del departamento.

7.2 Consenso informal, adaptación al contexto y reglas de decisión.

Las pautas preliminares se discutieron rondas sincrónicas y asincrónicas con tres tipos de actores: 1. Expertas familiaristas vinculadas al proceso de implementación de las unidades de análisis del PIC. 2. Referentes de la secretaria de salud de Boyacá, 3. Equipos territoriales y 4. Equipo de docentes de la especialidad de Medicina Familiar de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)buscando asegurar pertinencia territorial y aplicabilidad en el entorno hogar. La aprobación de cada pauta se realizó mediante deliberación y acuerdo informal.

8. Resultados: Síntesis narrativa de la evidencia.

8.1 Pregunta 1.

En familias abordadas en el hogar o en atención primaria/comunitaria, ¿qué escalas o herramientas de riesgo cardiovascular muestran mejor desempeño y factibilidad para clasificar el riesgo y orientar decisiones de cuidado?

Síntesis de la evidencia.

Con base en la revisión realizada en el marco del proceso de actualización parcial de la Guia de Práctica Clínica de Hipertensión Arterial Primaria en Colombia, se realizó la adaptación al presente documento de pauta de cuidado para el entorno hogar. A partir de la GPC, se establece que en adultos atendidos en el hogar o en atención primaria/comunitaria, la

estratificación del riesgo cardiovascular debe basarse en herramientas con buen desempeño predictivo, aplicabilidad local y factibilidad operativa. De acuerdo con la Guía colombiana actualizada en 2025, la herramienta con mejor soporte para clasificar el riesgo cardiovascular y orientar decisiones de cuidado en Colombia es SCORE2 recalibrado para Colombia (SCORE2-PURE). Esta escala es actualmente la opción principal recomendada para adultos por presentar el mejor equilibrio entre discriminación, calibración local y utilidad clínica para la toma de decisiones en atención primaria.

La preferencia por SCORE2-PURE se sustenta en la validación externa realizada en la cohorte PURE-Colombia, en la que se compararon seis modelos internacionales de predicción de riesgo cardiovascular. En esta evaluación, SCORE2 mostró la menor sobreestimación del riesgo antes de la recalibración y, tras aplicar factores de ajuste específicos para Colombia, alcanzó el mejor ajuste entre riesgo predicho y observado. Además, presentó un desempeño discriminativo adecuado y estable entre sexos, lo que lo convierte en la herramienta más pertinente para estandarizar la clasificación del riesgo cardiovascular en el contexto colombiano.

Desde una perspectiva de implementación, SCORE2-PURE resulta especialmente útil en atención primaria y comunitaria porque se basa en variables clínicas de uso rutinario, puede integrarse a calculadoras o plataformas digitales y favorece decisiones homogéneas sobre intensidad del tratamiento, seguimiento y remisión. Su uso permite priorizar a quienes tienen mayor riesgo absoluto, orientar la intensidad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, y fortalecer la comunicación del riesgo con la persona y su familia. En consecuencia, su utilidad no es únicamente predictiva, sino también programática y organizacional.

No obstante, la guía también precisa límites importantes para su uso. SCORE2-PURE funciona mejor en personas entre 40 y 69 años, que corresponde al grupo central de la validación. En menores de 40 años, las escalas tradicionales pueden subestimar el riesgo cuando existe acumulación de factores predisponentes, por lo que la clasificación debe complementarse con juicio clínico integral. En mayores de 70 años, la estimación debe interpretarse con cautela y complementarse con valoración geriátrica, multimorbilidad, fragilidad y competencia de riesgos. De igual forma, en personas con diabetes, enfermedad renal crónica, síndrome metabólico, albuminuria, antecedentes obstétricos como preeclampsia o diabetes gestacional, enfermedades autoinmunes, trastornos mentales graves, uso crónico de corticoides o infección por

VIH, la escala debe complementarse con predictores clínicos adicionales no plenamente capturados por el modelo.

Como herramientas alternativas o complementarias, la guía reconoce que existen modelos con aceptabilidad o factibilidad operativa, pero con menor sustento local para ser recomendados como primera línea. Entre ellos, Globorisk-LAC aparece como una alternativa regional promisoria, calibrada para América Latina y el Caribe, con desempeño discriminativo aceptable, aunque todavía requiere validaciones adicionales y ajustes específicos por país antes de adoptarse como referencia principal en Colombia. De forma similar, ASCVD/PCE ajustado o recalibrado muestra un desempeño intermedio y mejor que modelos clásicos como Framingham, pero no supera a SCORE2-PURE en calibración y pertinencia para el contexto colombiano.

En escenarios de atención primaria con limitaciones de laboratorio, rurales o con menor disponibilidad tecnológica, la guía sugiere considerar estrategias de implementación progresiva apoyadas en herramientas más simples y de alta factibilidad, como HEARTS OPS/OMS o INTERHEART sin laboratorio (NL-IHRS). Estas herramientas no son las de mejor exactitud predictiva para Colombia, pero tienen ventajas operativas: usan variables clínicas sencillas, pueden aplicarse con bajo costo, facilitan cobertura amplia y son útiles como instrumentos pragmáticos cuando no es posible utilizar de manera inmediata escalas recalibradas con mayor precisión. En particular, HEARTS tiene alta aceptabilidad programática en las Américas por su alineación con la APS, su disponibilidad gratuita y su facilidad de incorporación en rutas estandarizadas de manejo cardiovascular. INTERHEART sin laboratorio también ofrece utilidad potencial en contextos con recursos limitados, aunque la evidencia regional aún es insuficiente para posicionarlo como primera elección.

Por el contrario, la guía recomienda no utilizar Framingham ni PROCAM como herramientas de primera línea en Colombia. Framingham mostró sobreestimación importante del riesgo y peor calibración en la validación colombiana, mientras que PROCAM se considera metodológicamente obsoleto para predicción cardiovascular global y carece de validación pertinente para América Latina. Su uso puede inducir decisiones clínicas inadecuadas, especialmente por sobredimensionamiento del riesgo y menor pertinencia para contextos epidemiológicos y sociales distintos a aquellos donde fueron desarrollados.

En términos de aceptabilidad y factibilidad, la evidencia sintetizada en la guía indica que las herramientas de estratificación del riesgo cardiovascular son más útiles cuando cumplen cuatro condiciones: simplicidad operativa, uso de variables clínicas rutinarias, integración a los flujos de trabajo de la atención primaria y disponibilidad de soporte

tecnológico y capacitación del personal. En Colombia, las barreras principales para su implementación incluyen fragmentación entre aseguradores y prestadores, baja interoperabilidad, déficit de capacitación y escasa integración de la estratificación de riesgo en la práctica cotidiana. Sin embargo, estas barreras no invalidan el uso de las escalas; más bien señalan la necesidad de fortalecer procesos de formación, soporte técnico y articulación institucional.

En síntesis, para adultos atendidos en el hogar o en atención primaria/comunitaria, la herramienta con mejor desempeño y mayor pertinencia para clasificar el riesgo cardiovascular y orientar decisiones de cuidado en Colombia es SCORE2-PURE, por su validación externa nacional, mejor calibración local y buena factibilidad para integrarse en decisiones clínicas basadas en riesgo absoluto. Como alternativas operativas en contextos con limitaciones de recursos pueden emplearse HEARTS OPS/OMS o INTERHEART sin laboratorio, especialmente como estrategias pragmáticas de cobertura y tamización, mientras que Globorisk-LAC y ASCVD recalibrado pueden considerarse herramientas complementarias, aunque con menor respaldo para desplazar a SCORE2-PURE como primera opción. Framingham y PROCAM no deben usarse como herramientas de primera línea en el contexto colombiano.

Para facilitar la implementación de la recomendación, el equipo desarrollador y de AT de PIC-PICF de la secretaria de salud de Boyacá, a desarrollado con soporte en la Inteligencia Artificial Generativa una calculadora con el ajuste de SCRORE2-PURE, de acuerdo con la recomendación, la cual se puede considerar una herramienta de implementación en prueba.

De manera complementaria, el Consenso colombiano para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias en adultos propone una estrategia secuencial de evaluación del riesgo cardiovascular en cuatro pasos, que permite clasificar a la persona en riesgo muy alto, alto, moderado o bajo: 1) identificación de condiciones de muy alto riesgo; 2) identificación de condiciones de alto riesgo; 3) búsqueda de factores potenciadores del riesgo no incluidos en las escalas tradicionales, como enfermedades inflamatorias crónicas, condiciones específicas de la mujer, lipoproteína(a) elevada y pobreza multidimensional como determinante social de la salud, y 4) solo para quienes no quedan clasificados en los pasos anteriores, cálculo del riesgo a 10 años mediante una escala(9). Este abordaje evita subestimar el riesgo de las personas que ya cumplen criterios clínicos de riesgo alto o muy alto y permite que los equipos utilicen un lenguaje común antes de aplicar cualquier calculadora. Para el paso 4, el consenso propone la escala ASCVD ajustada para Colombia; en

coherencia con la GPC de HTA 2025, SCORE2-PURE se mantiene como herramienta principal en personas de 40 a 69 años(10) .

Como herramienta complementaria puede considerarse la ecuación PREVENT de la American Heart Association, aplicable entre los 30 y los 79 años, lo que amplía el rango de edad en el que es posible estimar el riesgo(11) . En una cohorte prospectiva de adultos mayores del nororiente colombiano (Bucaramanga, 2014-2024; n = 10.541)(10) , PREVENT mostró mejor discriminación que las Pooled Cohort Equations para mortalidad cardiovascular (estadístico C de 0,870 frente a 0,852; $p < 0,001$) y una mejora neta de reclasificación global de 0,094, mayor en hombres que en mujeres, aunque con una calibración perfectible (11) . Por ello, su uso debe ser complementario, y no sustitutivo, del juicio clínico y de los pasos 1 a 3 de la estrategia nacional, en especial en mujeres y en personas con determinantes sociales adversos, que PREVENT no captura de forma explícita.

8.2 Pregunta 2.

En personas adultas y familias con riesgo cardiovascular abordadas en el entorno hogar, ¿qué intervenciones familiares o domiciliarias son efectivas y factibles para reducir el riesgo cardiovascular y controlar sus factores de riesgo, y cómo deben priorizarse según el nivel de riesgo cardiovascular?

Síntesis de evidencia:

Para responder a esta pregunta se revisaron y analizaron 9 documentos, dentro de los cuales se encuentran 5 GPC y 4 consensos, en ellas es posible identificar que en personas adultas y familias con riesgo cardiovascular abordadas en el entorno hogar, las intervenciones más efectivas y factibles son aquellas de carácter multicomponente, que combinan educación en salud, consejería conductual, establecimiento de metas, seguimiento periódico, automonitoreo y acompañamiento por personal de salud o agentes comunitarios. En conjunto, estas intervenciones logran mejores resultados que las estrategias de un solo componente, particularmente sobre actividad física, alimentación, control de peso, presión arterial y algunos indicadores metabólicos. Además, su implementación es más sólida cuando se desarrollan desde atención primaria y comunidad, con enfoque familiar, culturalmente adaptado y sensible a barreras sociales y territoriales (12–16) .

En actividad física, la evidencia disponible permite una formulación operativa relativamente precisa. La GPC colombiana de HTA 2025 recomienda promover programas de ejercicio estructurado con al menos 150 minutos por semana de actividad aeróbica moderada, o una

combinación equivalente con actividad vigorosa, complementados con 2 a 3 sesiones semanales de entrenamiento de fuerza, ejercicios interválicos o ejercicios isométricos. La guía también da ejemplos concretos, como caminar rápido, correr, montar bicicleta, realizar sentadillas isométricas o ejercicios de "fuerza de agarre", y clasifica la intensidad usando MET (Equivalente Metabólico de la Tarea, por sus siglas en inglés), porcentaje de frecuencia cardiaca y prueba del habla (12,17)

En alimentación, las recomendaciones también permiten una formulación concreta. La AHA 2026 indica que un patrón alimentario cardioprotector debe priorizar frutas y verduras, granos enteros, proteínas saludables, grasas insaturadas y alimentos mínimamente procesados, y minimizar sodio, azúcares añadidos, ultraprocesados y alcohol(16) . La GPC HTA 2025 coincide en que la reducción del sodio, la mejoría del patrón dietario y el control del peso son intervenciones centrales y costo-efectivas. Para el entorno hogar, esto sugiere que el lineamiento debe ir más allá de recomendaciones genéricas y traducirse en orientaciones familiares sobre compra, preparación, distribución y consumo de alimentos(12) .

La evidencia que soportan las recomendaciones en las GPC, muestra que el cómo se implementan las intervenciones es tan importante como el contenido. Las intervenciones más efectivas suelen incluir coaching o consejería, establecimiento de metas, automonitoreo y seguimiento presencial o híbrido. Frith encontró que los programas con educación más coaching, metas y automonitoreo fueron superiores a los de un solo componente (15) , mientras que Tan identificó que las visitas domiciliarias, el empoderamiento del participante y el refuerzo periódico mejoraban la efectividad de las intervenciones lideradas por enfermería(14). Ndejjo, además, mostró que la combinación de educación, movilización comunitaria, consejería, tamizaje y seguimiento mejora conocimiento, dieta y actividad física en países de ingresos bajos y medios(13).

Frente a hábitos de tabaquismo y alcohol, la evidencia es algo menos uniforme respecto a las mejores estrategias de implementación, pero la dirección global es clara(18) . La GPC HTA 2025 recomienda indagar de forma rutinaria el consumo de tabaco, aconsejar el cese total y ofrecer apoyo farmacológico, no farmacológico y remisión cuando se requiera(12). En cuanto al alcohol, la declaración científica de la AHA 2025 resalta que el consumo alto o episódico se asocia consistentemente con peores desenlaces cardiovasculares y que no debe recomendarse iniciar el consumo por motivos de salud cardiovascular(16) . Esto permite incorporar ambos componentes dentro del abordaje familiar, especialmente como parte de programas integrales de reducción de riesgo.

Respecto a la priorización según nivel de riesgo, la evidencia apoya un enfoque escalonado e intensificado por riesgo. Aunque la literatura revisada no siempre clasifica formalmente las intervenciones domiciliarias por categorías de riesgo, sí permite inferir que la intensidad del acompañamiento debe ser mayor en personas y familias con más factores acumulados o mayor riesgo absoluto. El planteamiento de Khan, centrado en prevención guiada por riesgo y beneficio esperado, refuerza la idea de intensificar las acciones en grupos de alto riesgo primario(16). Traducido al ámbito del hogar, esto significa que las personas con hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, dislipidemia, enfermedad renal o multimorbilidad requieren intervenciones más intensivas, con mayor frecuencia de seguimiento, automonitoreo, visitas domiciliarias o acompañamiento más cercano; en cambio, en personas con riesgo bajo o intermedio pueden ser suficientes la consejería estructurada, la educación y el refuerzo periódico(14,15).

La evidencia insiste en que la efectividad de estas intervenciones depende también de su adaptación al contexto social y familiar. La ACC/AHA 2019 enfatiza el trabajo en equipo, la toma de decisiones compartida y la consideración de los determinantes sociales de la salud(17) De forma consistente, la GPC HTA 2025 y la revisión de Frith subrayan que las recomendaciones deben ajustarse al territorio, género, nivel educativo, recursos económicos, disponibilidad de alimentos saludables, seguridad del entorno y posibilidades reales de la familia para sostener cambios en el tiempo(12,15). Por tanto, se debe promover no solo acciones técnicamente efectivas, sino también intervenciones pertinentes, equitativas y factibles en las condiciones concretas del hogar.

De forma complementaria, el marco Life's Essential 8 (LE8) de la American Heart Association integra ocho componentes de la salud cardiovascular: alimentación saludable, actividad física, no exposición al tabaco, sueño adecuado, peso saludable y control del colesterol, la glucemia y la presión arterial; para los adultos, propone una duración del sueño de 7 a 9 horas por noche (19). Por tratarse de componentes de bajo costo y fácil comunicación, este marco resulta útil para organizar las intervenciones en el entorno familiar, puede beneficiar simultáneamente a todos los convivientes y contribuir a reforzar la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico.

8.3 Pregunta 3.

En personas adultas con riesgo cardiovascular y sus familias, atendidas en el hogar, ¿qué criterios clínicos, signos de alarma y

hallazgos iniciales deben considerarse para activar la atención urgente, la remisión o la referencia oportuna?

Síntesis de la evidencia:

Se revisaron seis GPC, cuatro revisiones sistemáticas y la Ruta Integral de Atención RIA Cardiovascular para responder a la pregunta, estas fuentes de evidencia indirecta identifican que en condiciones como accidente cerebrovascular (ACV), infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardiaca existe intervenciones sobre criterios clínicos, signos de alarma y hallazgos clínicos que en el entorno hogar pueden ser reconocidos por la familia y el equipo de salud para activar rutas o modalidades de atención de manera oportuna para reducir eventos cardiovasculares mayores. La evidencia disponible es heterogénea según el evento cardiovascular. El mayor respaldo corresponde al reconocimiento temprano y la activación de rutas de atención ante sospecha de ACV; para hipertensión y riesgo cardiovascular, la evidencia respalda la identificación de daño de órgano y de deterioro clínico como elementos para escalar la atención, y para síndrome coronario agudo e insuficiencia cardiaca aguda respalda el principio de atención oportuna, aunque requiere complementarse con guías específicas de signos y criterios de referencia antes de establecer criterios operativos definitivos. En el caso del ACV, la revisión sistemática de Almunif et al. demuestra que las herramientas estructuradas de reconocimiento precoz, como FAST, ROSIER, CPSS y NIHSS, tienen alta sensibilidad para identificar casos sospechosos en atención primaria, prehospitalaria y urgencias, aunque con especificidad variable(20).

No obstante, estas herramientas no son equivalentes en su uso: FAST y CPSS cuentan con buen respaldo para el reconocimiento inicial de la sospecha de ACV en los ámbitos comunitario y prehospitalario; ROSIER está orientada principalmente a profesionales de salud, y NIHSS es una escala clínica estructurada que requiere personal entrenado y se utiliza sobre todo para cuantificar el déficit neurológico y apoyar decisiones hospitalarias. Por ello, para la familia y la comunidad se recomienda una estrategia sencilla de reconocimiento de signos de alarma, mientras que las escalas clínicas estructuradas corresponden al equipo de salud capacitado y su aplicación no debe retrasar la referencia.

Además, muestra que la referencia temprana y los sistemas organizados de triage como la prenotificación por servicios de emergencias reducen los tiempos de acceso, aumentan la elegibilidad para terapias de reperfusión y mejoran desenlaces clínicos, incluidos mortalidad e independencia funcional. Esta evidencia sustenta que, ante signos súbitos compatibles con ACV, la prioridad debe ser el reconocimiento inmediato,

la activación urgente del sistema de referencia y la minimización de retrasos prehospitalarios(20).

La revisión de Abbasian et al. complementa esta evidencia desde el componente comunitario y domiciliario. La mayoría de intervenciones incluidas se enfocaron en el reconocimiento de signos y síntomas de ACV, y las campañas basadas en el acrónimo FAST en inglés fueron las más frecuentes para educar a la población sobre caída facial, debilidad de brazo, alteración del habla y la importancia del tiempo(21). En el caso de la sociedad española del corazón, sugieren el uso del acrónimo RÁPIDO en español como aspecto de adaptación transcultural. Este acrónimo funciona como estrategia educativa para el reconocimiento de signos de alarma y la activación del sistema de emergencias; sus letras equivalen a: Rostro caído, Alteración del equilibrio, Pérdida de fuerza, Impedimento visual, Dificultad para hablar, Obtenga ayuda rápido. En el contexto regional, el acrónico CORRE es altamente utilizado, se deriva de una adaptación de FAST y RÁPIDO que incorpora, además, las alteraciones visuales súbitas.

También se documentó que las campañas multimedia, la educación por enfermería y las estrategias multinivel mejoraron el reconocimiento de los signos de alarma, aumentaron la intención de llamar a los servicios de emergencia. Esta evidencia es particularmente pertinente para el entorno hogar, porque muestra que la educación estructurada sí puede transformar la capacidad de las familias para identificar tempranamente el ACV y activar la consulta urgente(21,22).

Desde el punto de vista de la hipertensión arterial y el riesgo de descompensación cardiovascular, la GPC colombiana de HTA 2025 aporta criterios clínicos útiles para el nivel primario. La guía recomienda informar a las personas sobre el significado de la presión arterial, sus valores normales y los umbrales de consulta, e indica que debe buscarse atención oportuna cuando existan cifras repetidas por encima de los rangos normales o síntomas sugerentes: 130/80 mm de Hg. Asimismo, en el abordaje inicial exige una anamnesis dirigida con búsqueda de signos y síntomas de daño de órgano mediado por hipertensión, hallazgos de posible hipertensión secundaria y documentación de factores de riesgo asociados (12). En el examen inicial se incluyen evaluación neurológica, estado cognitivo, palpación y auscultación cardiovascular, evaluación vascular periférica y comparación de presión arterial en ambos brazos. De manera consistente con la prevención de eventos mayores, la guía también recomienda indicar neuroimagen cuando existan signos neurológicos focales, quejas cognitivas o antecedente de enfermedad cerebrovascular, y establece que, ante la detección de daño a órgano

blanco, no debe retrasarse el inicio del tratamiento antihipertensivo mientras se completan estudios complementarios(12).

Los lineamientos de la Ruta Integral de Atención en Salud para personas con riesgo o presencia de alteraciones cardio-cerebro-vascular-metabólicas manifiestas aportan la arquitectura operativa para traducir estos hallazgos a una ruta de acción(23). El documento establece que la ruta debe identificar e intervenir oportunamente factores de riesgo y enfermedades manifiestas para evitar la aparición o progresión de enfermedad y sus desenlaces fatales. En el componente primario, exige garantizar oportunidad, continuidad y calidad de las intervenciones requeridas, y señala expresamente que las atenciones de la ruta no pueden convertirse en barrera de acceso para otras valoraciones, procedimientos, exámenes o tratamientos que el médico tratante considere necesarios. También precisa que la valoración inicial debe incluir la valoración del riesgo cardiovascular y metabólico actual, la identificación de factores de riesgo modificables, la interpretación o solicitud de exámenes según hallazgos y el diagnóstico de condiciones como prehipertensión, hipertensión, prediabetes, diabetes, dislipidemia, obesidad o enfermedad renal crónica. Esto respalda que, desde APS, los hallazgos iniciales deben servir no solo para clasificar riesgo sino también para decidir tempranamente cuándo escalar la atención(23).

De manera complementaria, la guía NICE 2023 recomienda usar en APS una estrategia sistemática para identificar personas con alto riesgo cardiovascular, priorizar a quienes requieren evaluación formal, revisar el riesgo de manera continua y utilizar QRISK3 para la estimación del riesgo en personas sin enfermedad cardiovascular establecida. Además, indica que algunos grupos pueden tener riesgo subestimado por las herramientas y que la interpretación debe complementarse con juicio clínico, particularmente cuando existen factores no totalmente capturados por los modelos o cuando el riesgo real puede ser mayor que el estimado(24). También resalta la necesidad de dedicar tiempo suficiente a la comunicación del riesgo, promover decisiones compartidas y reevaluar a las personas que rechazan o difieren intervenciones preventivas(24).

En términos de oportunidad diagnóstica y terapéutica, la evidencia es particularmente precisa para ACV. La revisión de Almunif et al. recuerda que la atención del ACV es altamente tiempo-dependiente, en la medida en que la trombólisis intravenosa es más efectiva dentro de las primeras 4.5 horas y la trombectomía puede beneficiar pacientes seleccionados hasta 24 horas(20). Los estudios incluidos muestran que las estrategias estructuradas de reconocimiento y referencia pueden reducir en 12 a 22 minutos el tiempo desde inicio de síntomas hasta llegada al hospital y

aumentar entre 7% y 12% la elegibilidad para reperfusión. Por tanto, para el lineamiento, el principio rector debe ser que cualquier familia o equipo de APS que identifique signos compatibles con ACV debe activar de inmediato la ruta de urgencias y minimizar cualquier retraso administrativo o clínico(20).

Con base en el conjunto de evidencia, puede proponerse que los criterios de alarma y activación de rutas desde el hogar y el nivel primario se organicen en tres niveles. Primero, un nivel de alarma domiciliaria, centrado en síntomas de aparición súbita sugestivos de ACV, asimetría facial, debilidad de brazo, alteración del habla y, en el caso de hipertensión o riesgo cardiovascular alto, en la presencia de cifras tensionales persistentemente elevadas o síntomas sugerentes que obliguen a consulta o evaluación pronta. Segundo, un nivel de hallazgos iniciales en APS, que incluye evidencia o sospecha de daño a órgano blanco, signos neurológicos focales, deterioro cognitivo, progresión clínica, control inadecuado del riesgo o sospecha de causas secundarias, lo que debe conducir a exámenes complementarios, neuroimagen cuando corresponda y remisión prioritaria. Tercero, un nivel de activación de red, donde la organización del sistema debe asegurar acceso sin barreras, continuidad, articulación con servicios de emergencias y disponibilidad de referencia oportuna según complejidad (12,20,23,24).

En síntesis, la evidencia disponible apoya que, en familias con miembros con riesgo cardiovascular o sospecha de descompensación cardiovascular atendidas en el hogar o en el nivel primario, la activación oportuna de rutas debe apoyarse en: reconocimiento temprano de signos neurológicos súbitos compatibles con ACV, educación familiar en señales de alarma y búsqueda inmediata de ayuda, identificación clínica de daño a órgano blanco o descompensación asociada a hipertensión, y uso de una red organizada de atención que garantice oportunidad, continuidad y referencia sin barreras. La evidencia es directa y fuerte para ACV, complementaria pero útil para hipertensión y riesgo cardiovascular global, y contextual para la organización sistemática de la identificación y reevaluación del riesgo en APS a partir de NICE 2023. Para IAM e insuficiencia cardiaca, los documentos aquí revisados respaldan los principios de oportunidad y escalamiento, aunque sería deseable complementar posteriormente con guías específicas para fortalecer la precisión clínica de signos de alarma por evento (22,25).

8.4 Pregunta 4.

¿Qué estrategias en el entorno hogar deben usarse para favorecer la adherencia farmacológica en personas adultas con riesgo cardiovascular y sus familias?

Síntesis de la evidencia:

Se incluyeron en la síntesis de evidencia un total de 19 fuentes de evidencia para responder a la pregunta sobre la adherencia. Con base en el contenido temático, estas fuentes se organizaron en 3 grupos que se presentan a continuación. La evidencia del primer grupo corresponde principalmente a revisiones sistemáticas sobre intervenciones generales para mejorar la adherencia farmacológica en enfermedades crónicas, con contribuciones más específicas en hipertensión, dislipidemia, insuficiencia cardiaca, accidente cerebrovascular y manejo cardiovascular ambulatorio. En conjunto, estos documentos permiten identificar patrones consistentes sobre qué tipos de estrategias muestran mayor promesa para apoyar la adherencia en el entorno hogar, dentro de las cuales se establecen: simplificación de regímenes, educación estructurada, recordatorios, apoyo profesional continuo, intervenciones multicomponente y, en algunos contextos, participación de la familia o del cuidador. No obstante, la evidencia también muestra que los efectos suelen ser modestos y heterogéneos, y que las intervenciones más eficaces suelen ser complejas, intensivas o difíciles de trasladar de forma directa a la práctica rutinaria, por lo que la implementación se ve comprometida por la factibilidad y la aplicabilidad al hogar.

Con base en la evidencia disponible, se identifica que las intervenciones generales para mejorar la adherencia farmacológica en enfermedades crónicas y cardiovasculares tienden a ser más efectivas cuando combinan varios componentes y reducen barreras cotidianas concretas para tomar los medicamentos. De forma consistente, las revisiones coinciden en que las estrategias con mayor promesa incluyen la simplificación del régimen farmacológico, cuando sea clínicamente apropiado y decidido por el profesional tratante, la educación estructurada al paciente, los recordatorios y el acompañamiento profesional continuado, mientras que la educación aislada tiende a mostrar un rendimiento más limitado. Anderson, en su revisión de revisiones sistemáticas, identificó como estrategias más consistentemente efectivas la simplificación de dosis, la educación, los recordatorios electrónicos y la reducción de costos o incentivos, aunque resaltó que gran parte de la evidencia subyacente sigue siendo de baja calidad(26). De manera convergente, Schroeder encontró que la reducción del número de dosis diarias en HTA fue la

intervención con resultados más consistentes, mientras que la educación sola fue generalmente poco efectiva (27).

En las condiciones cardiovasculares más cercanas a la pregunta 4, la evidencia sugiere que las intervenciones de adherencia funcionan mejor cuando se integran dentro de un seguimiento clínico activo y no como acciones aisladas. En dislipidemia, van Driel mostró que las estrategias de "intensificación del cuidado" como, recordatorios electrónicos, intervención farmacéutica y educación por profesionales, mejoraron la adherencia en el corto y largo plazo y también se asociaron con mejores niveles de colesterol total y LDL(28). Kengne et al, en una revisión enfocada en hipertensión y dislipidemia, encontró que la mayoría de los estudios con educación en salud, recordatorios telefónicos y aplicaciones digitales reportaron mejoras en adherencia, aunque la persistencia terapéutica fue mucho menos evaluada(29). Esto es relevante porque permite priorizar medidas aplicables en el hogar que combinen educación práctica, seguimiento remoto sencillo y refuerzo continuo.

Las intervenciones lideradas por enfermería también muestran un lugar importante en este grupo de evidencia. Berardinelli encontró que las visitas presenciales y los modelos mixtos con seguimiento telefónico fueron más efectivos que las estrategias exclusivamente remotas para mejorar la adherencia en enfermedades crónicas, incluyendo hipertensión, enfermedad coronaria e insuficiencia cardiaca(30). En una línea complementaria, El Hussein identificó en personas mayores con insuficiencia cardiaca que las intervenciones más destacadas se agrupan en cuatro ejes: alfabetización en salud, aplicaciones móviles, rehabilitación personalizada y recordatorios móviles programados(31). En conjunto, estas revisiones sugieren que el contacto humano, la educación adaptada y los recordatorios estructurados siguen siendo más robustos que las intervenciones puramente tecnológicas cuando se trata de sostener la adherencia en casa(30,31).

En cuanto a apoyos prácticos de bajo costo en el hogar, la revisión Cochrane de Mahtani mostró que los empaques recordatorios, como pastilleros o blísteres calendario, pueden incrementar modestamente la toma de medicamentos y en algunos estudios mejorar resultados clínicos intermedios, aunque la certeza de la evidencia fue baja o muy baja (32). A pesar de esa limitación, su bajo costo, simplicidad y posible utilidad en personas con menor alfabetización los vuelve especialmente atractivos como recomendación factible en el ámbito familiar.

Sin embargo, la evidencia más reciente muestra que no son contundentes las intervenciones sobre adherencia, la revisión Cochrane de Nieuwlaat, que sintetizó 182 ensayos, concluyó que solo una minoría de estudios de menor riesgo de sesgo logró mejorar simultáneamente adherencia y

desenlaces clínicos, y que los programas eficaces tendían a ser complejos, individualizados y con apoyo continuo de profesionales, familia o pares(25). De forma similar, la revisión de Cadel en personas con ACV mostró que la adherencia suele incorporarse como parte de programas más amplios de automanejo, prevención secundaria y control de factores de riesgo, más que como intervención aislada(33). Esto sugiere que la adherencia farmacológica debe concebirse dentro de un enfoque integral de cuidado domiciliario y familiar, no como una acción única descontextualizada.

De manera indirecta, la evidencia procedente de otras condiciones que requieren tratamientos prolongados, como la tuberculosis, sugiere que la educación, los incentivos, los recordatorios, las intervenciones psicológicas y el acompañamiento comunitario mejoran la adherencia y los desenlaces del tratamiento frente a la administración no supervisada(34). Aunque esta evidencia es distante de la pregunta, refuerza la plausibilidad de que los componentes de apoyo continuo, recordatorio y acompañamiento también sean útiles en personas con riesgo cardiovascular que reciben medicamentos.

Un segundo grupo de fuentes de evidencia agrupo las revisiones sistemáticas sobre intervenciones digitales, basadas en dispositivos móviles, app u otras plataformas tecnológicas. La evidencia de este grupo muestra que este tipo de intervenciones son heterogéneas frente a los efectos que logran en la mejora de la adherencia a los medicamentos y sus resultados dependen en gran medida el tipo de tecnología, del nivel de interacción que permiten, del tiempo de seguimiento y de si se articulan o no con apoyo profesional. En general, las revisiones coinciden en que las soluciones tecnológicas aisladas muestran efectos variables, mientras que las intervenciones que incorporan educación, monitoreo, retroalimentación o acompañamiento clínico tienden a mostrar mejores resultados (35).

En hipertensión, diabetes y dislipidemia, Bingham encontró que las intervenciones de eHealth y telehealth se asociaron con mejoría en adherencia medida por el MPR (Índice de Posesión de Medicamentos) y el el PDC (Proporción de Días Cubiertos), mientras que las intervenciones de mHealth no mostraron una mejoría consistente(35). Esto sugiere que no toda tecnología móvil produce el mismo efecto y que las modalidades con mayor estructuración y acompañamiento pueden ser superiores a soluciones móviles simples. En una línea similar, Conway y Kelechi, revisaron 13 estudios de salud digital en diabetes o hipertensión y concluyeron que no había evidencia concluyente de mejoría de la adherencia con respuesta de voz interactiva (IVR) y los mensajes de texto (SMS), telemonitorización o software interactivo, aunque sí observaron

un potencial importante para facilitar educación y comunicación entre pacientes y prestadores de servicios de salud(36).

Cuando la tecnología se concentra en recordatorios o mensajería, la evidencia es más matizada. La revisión de Chun-Yun sobre antihipertensivos identificó 12 ensayos y encontró que solo 5 lograron mejoras significativas en adherencia, y únicamente 2 de ellos también mejoraron la presión arterial. Entre las intervenciones exitosas estuvieron las tapas electrónicas con recordatorio audiovisual, los SMS educativos, el reporte de presión arterial a sistemas telefónicos y el envío de videos de la toma del medicamento con incentivos(37). Estos hallazgos sugieren que los recordatorios funcionan mejor cuando se combinan con elementos de información, verificación o respuesta del sistema, y no cuando operan solo como avisos pasivos.

Los mensajes de texto son probablemente la estrategia digital más atractiva por su bajo costo y alta factibilidad, pero la evidencia no es uniforme. En diabetes tipo 2, Belete encontró que los SMS mejoraron modestamente la adherencia frente al cuidado usual, con un efecto mayor cuando las intervenciones duraban más de seis meses (38). Esto sugiere que la continuidad es un componente importante para que la mensajería tenga utilidad clínica. Sin embargo, en el campo cardiovascular los resultados son menos consistentes. Palmer, en la revisión Cochrane de 2018(36) y su actualización de 2021(39) para prevención primaria cardiovascular, concluyó que la evidencia era de baja certeza, con efectos pequeños, modestos o nulos según el estudio. En particular, la actualización de 2021 mostró que los SMS solos probablemente producen poco o ningún beneficio en presión arterial, mientras que las estrategias que incluyen automonitoreo de presión arterial con apoyo de telemedicina móvil parecen más prometedoras(39).

En prevención secundaria, la revisión Cochrane más reciente de Redfern, con 18 ensayos, mostró que 10 estudios encontraron beneficios en adherencia y 8 no, de modo que el efecto global de los SMS sobre adherencia quedó como muy incierto(40). Además, los mensajes de texto probablemente tienen poco o ningún efecto sobre eventos cardiovasculares fatales y muy incierto efecto sobre LDL, presión arterial y frecuencia cardiaca(40). De forma convergente, la revisión de Sua en cardiopatía coronaria encontró que las intervenciones móviles de automanejo no lograron una mejoría estadísticamente significativa en adherencia farmacológica, aunque sí redujeron discretamente la presión diastólica (41). Estos hallazgos indican que, en personas con enfermedad cardiovascular establecida, la mensajería móvil puede ser útil como apoyo, pero difícilmente constituye por sí sola una intervención suficiente.

Las apps de automanejo parecen ofrecer un nivel de apoyo más completo que la simple mensajería, especialmente cuando integran educación, registro de datos y comunicación con el equipo tratante. Nkhoma mostró que las apps DSMES en diabetes tipo 2 tuvieron un efecto pequeño a moderado sobre adherencia a 3 meses, junto con mejorías en HbA1c y BMI (42). Además, las apps fueron descritas como confiables, fáciles de usar y convenientes. No obstante, esta ventaja tiene una condición clara y es que el paciente y, en muchos casos, su familia debe contar con suficiente alfabetización digital para utilizarlas de forma sostenida. Por tanto, aunque son prometedoras, su aplicabilidad no es universal (42).

En términos generales, las intervenciones digitales o móviles pueden contribuir a favorecer la adherencia farmacológica en el hogar, pero su efectividad es variable y parece ser mayor cuando se integran a modelos de apoyo más amplios. Los SMS pueden ser útiles como recordatorio de bajo costo, especialmente en diabetes y cuando se mantienen por periodos prolongados, pero en prevención cardiovascular sus beneficios son modestos o inciertos. Las apps y herramientas de telehealth/eHealth muestran mayor potencial cuando facilitan educación, automonitoreo y retroalimentación clínica. En consecuencia, se justificaría recomendar estas tecnologías como soportes complementarios, priorizando aquellas que sean simples, sostenibles y articuladas con seguimiento profesional y apoyo familiar, y evitando presentarlas como estrategia única para resolver la no adherencia (35–37,40).

El último grupo correspondió al conjunto de la evidencia disponible sobre intervenciones comportamentales y educativas, las cuales en general, muestran ser muy valiosas cuando abordan de manera simultánea, la comprensión del tratamiento, las creencias del paciente, la motivación para sostener la toma de medicamentos y las barreras prácticas del día a día. En este conjunto, la adherencia no aparece como un problema meramente técnico, sino como una conducta compleja influida por factores cognitivos, emocionales, familiares y relacionales. En consecuencia, el principal aporte de este grupo no es solo identificar "técnicas" educativas, sino mostrar cómo puede entenderse y abordarse la adherencia en enfermedades crónicas y cardiometabólicas(43,44).

La revisión de Archer aporta un marco interpretativo particularmente útil para el lineamiento al organizar los factores que influyen en adherencia mediante el modelo COM-B. Sus hallazgos muestran que la baja adherencia en diabetes tipo 2 se asocia con barreras en la capacidad psicológica, como por ejemplo, escaso conocimiento sobre diabetes, olvido y dificultades de automonitoreo, en la oportunidad física y social, dentro de las cuales encontramos la complejidad del tratamiento, costos, acceso a medicamentos, apoyo familiar insuficiente o mala comunicación

con el equipo tratante y en la motivación, incluyendo depresión, baja autoeficacia, preocupaciones por efectos adversos y percepciones negativas sobre la enfermedad o los medicamentos(43). En el lado opuesto, los facilitadores más consistentes fueron la educación del paciente, el apoyo de la familia, una relación terapéutica de buena calidad, la autoeficacia y los programas estructurados de educación(43). Esto indica que la adherencia farmacológica no debe pensarse solo como cumplimiento de una instrucción, sino como un comportamiento que requiere capacidades, oportunidades y motivaciones que pueden y deben ser fortalecidas.

La anterior visión es altamente consistente con la guía NICE sobre adherencia a medicamentos, la cual subraya que la no adherencia puede ser intencional, y se da cuando el paciente decide no seguir el tratamiento por sus creencias, preocupaciones o preferencias, o no intencional cuando existen barreras como olvido, dificultades de comprensión, problemas económicos o de uso del medicamento (45). La guía insiste en que la no adherencia no debe interpretarse como culpa del paciente, sino como una limitación del proceso asistencial que exige exploración abierta de perspectivas, creencias y necesidades. Asimismo, recomienda evaluar adherencia de forma rutinaria y no juzgadora, discutir beneficios y riesgos de los medicamentos, identificar preocupaciones, revisar periódicamente el conocimiento del paciente y adaptar cualquier apoyo a las barreras específicas detectadas. En términos prácticos, NICE respalda intervenciones como simplificación del régimen, registros de toma, apoyo al monitoreo de la condición, empaques alternativos o sistemas multicompartimento, pero solo cuando respondan a una necesidad individual concreta (45).

Dentro de las estrategias educativas específicas, la revisión de Ha Dinh sugiere que el método teach-back tiene especial valor. Esta estrategia consiste en pedir al paciente que explique con sus propias palabras lo que entendió sobre su enfermedad, tratamiento o autocuidado, de modo que el profesional pueda identificar vacíos de comprensión y corregirlos inmediatamente(46). La revisión encontró efectos positivos en distintos desenlaces de enfermedades crónicas, incluyendo mejoría en conocimiento específico, autoeficacia y autocuidado. En diabetes tipo 2, un estudio incluido mostró mejoría estadísticamente significativa en adherencia a medicación y dieta con teach-back frente a cuidado usual. Además, varios estudios mostraron mejoras en conductas concretas de autocuidado y tendencias favorables en reducción de readmisiones(46). Esto es particularmente relevante para el entorno hogar, porque sugiere que no basta con “dar información”; es necesario verificar la comprensión real, ajustar el mensaje y reforzarlo en el tiempo.

Otro hallazgo importante de este grupo es que la aceptabilidad y utilidad de las intervenciones mejora cuando el paciente percibe que estas respetan su autonomía y fortalecen, en lugar de reemplazar, la relación con el equipo de salud. La revisión cualitativa de Kobson muestra que los pacientes valoran las intervenciones de retroalimentación sobre adherencia cuando son fáciles de usar, proporcionan apoyo emocional o motivacional, y facilitan conversaciones no juzgadoras con los profesionales (47). Los participantes también destacaron la importancia de mantener control sobre sus datos, recibir retroalimentación comprensible y contar con un diseño adaptado a sus necesidades, edad, nivel de experiencia con la enfermedad o complejidad del tratamiento. Un elemento especialmente relevante es que los pacientes ven con buenos ojos la retroalimentación objetiva sobre adherencia cuando esta sirve para resolver problemas, comprender patrones de uso y apoyar la toma de decisiones compartidas(47).

En general, es posible considerar a partir de este tercer grupo de fuentes de evidencia que, en el entorno hogar, las estrategias para favorecer la adherencia farmacológica deben combinar educación estructurada, verificación de comprensión, exploración de creencias y preocupaciones sobre los medicamentos, fortalecimiento de la autoeficacia y apoyo familiar y profesional continuo basado en la exploración, escucha activa y no juzgamiento. El método teach-back emerge como una estrategia particularmente útil para asegurar que la persona comprendió cómo y por qué tomar sus medicamentos (46). A su vez, los hallazgos de Archer y la guía NICE muestran que la adherencia debe evaluarse y apoyarse distinguiendo barreras intencionales y no intencionales, con un enfoque no culpabilizante y centrado en la persona (43,44). Finalmente, la evidencia cualitativa sugiere que las intervenciones tienen mayor aceptabilidad cuando son simples, adaptadas a las necesidades del paciente, respetan su autonomía y fortalecen la relación con el equipo de salud. Por tanto, la educación no debe limitarse a entregar instrucciones, sino orientarse a construir comprensión, motivación y capacidad real de sostener el tratamiento en la vida cotidiana

Una mirada integradora de toda la evidencia para esta pregunta nos sugiere que las estrategias más pertinentes para favorecer la adherencia farmacológica en personas adultas con riesgo cardiovascular medicadas y sus familias en el entorno hogar son aquellas que combinan simplificación del régimen terapéutico cuando sea posible, educación estructurada y comprensible, verificación de la comprensión, recordatorios prácticos, seguimiento periódico y apoyo familiar o profesional continuo. Las intervenciones exclusivamente aisladas, por ejemplo, educación sin refuerzo o herramientas digitales sin acompañamiento muestran resultados más variables, mientras que los mejores hallazgos se observan

en intervenciones multicomponente, adaptadas a las barreras específicas de cada persona, incluyendo olvido, polifarmacia, efectos adversos, baja autoeficacia, depresión, dificultades de comunicación y problemas de acceso o continuidad del cuidado.

En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud señala que el acceso, la disponibilidad y la continuidad en el suministro de los medicamentos son determinantes del control de la hipertensión, además de los factores relacionados con la persona, por lo que las barreras del sistema de salud deben abordarse explícitamente junto con las individuales y familiares.

La evidencia también indica que las herramientas digitales pueden ser útiles como soporte, especialmente cuando facilitan recordatorios, automonitoreo y retroalimentación, pero no reemplazan el valor del contacto humano, la relación terapéutica y la participación de la familia. En consecuencia, para el lineamiento, la adherencia farmacológica debe abordarse como un proceso de cuidado centrado en la persona y su contexto cotidiano, con un enfoque no culpabilizante, de decisiones compartidas y de apoyos individualizados según barreras intencionales y no intencionales, más que como una responsabilidad exclusiva del paciente.

9. Pautas de cuidado basadas en la evidencia para el abordaje del riesgo cardiovascular en la familia.

9.1 Pautas generales

- En toda familia con uno o más integrantes con factores de riesgo cardiovascular, se recomienda abordar el riesgo cardiovascular como una condición individual y familiar. La valoración debe incluir los antecedentes y condiciones clínicas de cada persona, así como los patrones familiares de alimentación, actividad física, consumo de tabaco y alcohol, organización del cuidado, disponibilidad de medicamentos, apoyo familiar, condiciones económicas, acceso a servicios y características del territorio que puedan favorecer o dificultar el control del riesgo.

- Durante la visita domiciliaria, se recomienda involucrar a la persona en las decisiones sobre su cuidado y, con su consentimiento, incorporar a familiares o cuidadores en la definición de compromisos, el reconocimiento de signos de alarma, el seguimiento de las recomendaciones y el apoyo a la toma de medicamentos. La

participación familiar no debe sustituir la autonomía ni la capacidad de decisión de la persona.

- Las intervenciones acordadas con la familia deben registrarse en el plan de cuidado familiar, incluyendo como mínimo: nivel de riesgo identificado, factores de riesgo prioritarios, metas de cuidado, responsables de las acciones, apoyos requeridos, barreras previsibles, rutas activadas, prescripción social y fecha de seguimiento.

- Las recomendaciones deben adaptarse al nivel educativo y de alfabetización en salud, idioma, cultura alimentaria, edad, género, capacidad funcional, multimorbilidad, ruralidad, disponibilidad económica, conectividad, seguridad del entorno y acceso efectivo a alimentos, medicamentos, espacios para actividad física y servicios de salud.

- El abordaje realizado desde el PICF no reemplaza la valoración clínica, el diagnóstico ni el tratamiento que corresponde a los servicios de salud. Si durante la atención domiciliaria se identifican signos de alarma, descompensación, daño de órgano, riesgo elevado o necesidades diagnósticas o terapéuticas no resueltas, se debe activar la ruta correspondiente sin permitir que los procedimientos administrativos retrasen la atención.

9.2 Pautas pregunta 1. Establecimiento del riesgo cardiovascular.

- Se recomienda que la identificación de factores de riesgo y la estimación del riesgo cardiovascular descritas en esta sección sean realizadas por profesionales de enfermería, medicina general o medicina familiar (consenso de expertas).

- Se recomienda que los profesionales que abordan a la familia identifiquen los factores de riesgo y estimen el riesgo cardiovascular de todos los integrantes adultos de la familia, aunque no tengan una enfermedad crónica de base, utilizando la herramienta apropiada según la edad (consenso de expertas).

- Se sugiere que los profesionales consideren la obesidad y la dislipidemia como factores de riesgo mayores para enfermedad cardiovascular (ECV) e indaguen activamente su presencia en todos los integrantes de la familia; la obesidad no es una variable incluida en

SCORE2-PURE, por lo que debe valorarse de forma complementaria al resultado de la escala (consenso de expertas).

- Antes de aplicar cualquier escala de riesgo (SCORE2-PURE, PREVENT o ASCVD), se recomienda que los profesionales utilicen la estrategia de evaluación del riesgo cardiovascular en cuatro pasos del Consenso colombiano para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias en adultos (SCC, 2024) como marco de referencia nacional para la clasificación del riesgo. Las personas que cumplan criterios de riesgo muy alto o alto en los pasos 1 y 2 deben clasificarse como tales sin necesidad de cálculo adicional; en las demás, se deben identificar los factores potenciadores del paso 3 y solo después estimar el riesgo a 10 años con la escala correspondiente.

Paso	**Evaluación**	**Decisión**
1. Identificar condiciones de muy alto riesgo	Buscar condiciones que clasifican automáticamente al paciente como muy alto riesgo, entre ellas: enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida; aterosclerosis subclínica con placas ≥50% o características de vulnerabilidad; hipercolesterolemia familiar homocigótica; hipercolesterolemia familiar heterocigótica asociada a un factor de riesgo mayor; enfermedad renal crónica con TFGe ≤30 ml/min/1,73 m²; o diabetes con daño de órgano blanco, ≥3 factores de riesgo adicionales o larga duración.	Si presenta alguna de estas condiciones, se clasifica como muy alto riesgo cardiovascular y no es necesario continuar con la escala de riesgo.
2. Identificar condiciones de alto riesgo	Si no cumple criterios del paso 1, buscar características de alto riesgo, como múltiples factores de riesgo cardiovascular, aterosclerosis subclínica <50%, calcio coronario ≥100 UA o >p75, factores de riesgo marcadamente elevados, diabetes con factores adicionales, hipercolesterolemia familiar heterocigótica o ERC con TFGe de 30–60 ml/min/1,73 m².	Si presenta alguna de estas condiciones, se clasifica como alto riesgo cardiovascular.
3. Identificar potenciadores del riesgo	Si aún no ha sido clasificado, valorar potenciadores como enfermedades inflamatorias crónicas, antecedente familiar de ECV prematura, índice tobillo-brazo <0,9, biomarcadores elevados, condiciones específicas de la	Con 1–2 potenciadores, se considera riesgo moderado; con ≥3 potenciadores, se reclasifica como alto riesgo.

	mujer, diabetes sin otros factores y condiciones socioeconómicas adversas.	
4. Calcular riesgo cardiovascular a 10 años	Si después de los pasos anteriores persiste incertidumbre, calcular el riesgo con la escala SCORE2-PURE para mayores de 40 o PREVENT para menores.	<5%:** riesgo bajo; **5–20%:** riesgo moderado; **>20%: riesgo alto.

- En personas adultas entre 40 y 69 años que requieran clasificación del riesgo cardiovascular, se recomienda utilizar SCORE2 recalibrado para Colombia (SCORE2-PURE) como herramienta principal para estimar el riesgo cardiovascular absoluto y orientar la intensidad de las intervenciones, el seguimiento y la necesidad de evaluación adicional.

- Antes de calcular SCORE2-PURE, se recomienda verificar la calidad y actualidad de las variables clínicas requeridas. Cuando la información necesaria no se encuentre disponible durante la visita domiciliaria, se debe gestionar su obtención en el nivel primario y registrar que la clasificación está pendiente, sin asumir que la ausencia de información equivale a bajo riesgo.

- El resultado de SCORE2-PURE debe interpretarse conjuntamente con la historia clínica, los antecedentes personales y familiares, la presencia y control de factores de riesgo, la utilización reciente de servicios y las condiciones sociales y territoriales. La escala orienta la decisión, pero no reemplaza el juicio clínico ni la valoración integral de la persona y su familia.

- Una vez estimado el riesgo cardiovascular, se recomienda comunicar el resultado a la persona y su familia en un lenguaje comprensible. La comunicación debe explicar qué significa el nivel de riesgo, cuáles factores contribuyen a este, cuáles pueden modificarse y qué compromisos de cuidado se proponen para reducirlo.

- El nivel de riesgo identificado debe utilizarse para definir la intensidad del plan familiar. Las personas con mayor riesgo absoluto deben recibir intervenciones más intensivas, seguimiento más frecuente, revisión del tratamiento y articulación más estrecha con el nivel primario; las personas con riesgo bajo o intermedio deben recibir educación estructurada, metas de prevención y reevaluación periódica.

- En personas menores de 40 años, no se recomienda interpretar automáticamente una estimación baja como ausencia de riesgo. Si

existe acumulación de factores predisponentes, antecedentes familiares relevantes, obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo u otras condiciones clínicas, la clasificación debe complementarse con valoración integral y juicio clínico. En personas de 30 a 39 años puede utilizarse, además, la ecuación PREVENT, aplicable entre los 30 y los 79 años, como apoyo para estimar el riesgo.

- En personas menores de 40 años, se recomienda explorar de manera activa los factores de riesgo cardiovascular sin esperar a que se presente una enfermedad crónica de base (consenso de expertas).

- En personas de 70 años o más, la interpretación del riesgo debe complementarse con valoración de multimorbilidad, fragilidad, capacidad funcional, expectativa de vida, polifarmacia y competencia de riesgos. El resultado de una escala no debe conducir por sí solo a intensificar intervenciones sin considerar el balance individual entre beneficios, riesgos y preferencias. En personas de 70 a 79 años puede considerarse la ecuación PREVENT como herramienta complementaria, sin que reemplace dicha valoración integral. (Ver las pautas de cuidado para el abordaje de la persona mayor en el entorno hogar).

- En personas con diabetes, enfermedad renal crónica, síndrome metabólico, albuminuria, antecedentes de preeclampsia o diabetes gestacional, enfermedades autoinmunes, trastornos mentales graves, infección por VIH o uso crónico de corticoides, se recomienda clasificar el riesgo a partir de los pasos 1 a 3 de la estrategia del Consenso colombiano de dislipidemias, que incorpora muchas de estas condiciones como criterios de riesgo alto o muy alto o como factores potenciadores, y complementar cualquier estimación con SCORE2-PURE con los predictores clínicos específicos y el juicio profesional, dado que estas condiciones pueden no estar plenamente capturadas por el modelo.

- En contextos rurales, dispersos o con limitaciones de laboratorio o tecnología, cuando no sea posible utilizar inmediatamente SCORE2-PURE, se recomienda realizar una aproximación inicial al riesgo cardiovascular a partir de los antecedentes personales y familiares y de los factores de riesgo identificados, en especial exceso de peso (sobrepeso u obesidad, particularmente con perímetro abdominal aumentado) y antecedente de dislipidemia (consenso de expertas) para valoración y orientar la priorización inicial. Se debe registrar la herramienta utilizada y gestionar una evaluación más completa cuando esté indicada. En estos contextos, los pasos 1 a 3 de la estrategia del Consenso colombiano de dislipidemias permiten una clasificación inicial

basada en antecedentes y hallazgos clínicos, aun sin disponer de calculadora.

- No se recomienda utilizar Framingham ni PROCAM como herramientas de primera elección para clasificar el riesgo cardiovascular en Colombia, debido a la sobreestimación observada, la menor calibración local y la limitada pertinencia para el contexto epidemiológico nacional.

- Las instituciones responsables de la implementación deben garantizar capacitación del talento humano, disponibilidad de calculadoras verificadas, estandarización de las variables requeridas, registro del resultado y articulación del riesgo estimado con las decisiones de seguimiento, tratamiento y remisión.

- Si se utiliza la calculadora SCORE2-PURE desarrollada como herramienta de implementación del PICF, se recomienda someterla a verificación técnica y clínica antes de su adopción rutinaria, documentar la versión empleada y asegurar que el resultado sea revisado por personal competente antes de orientar decisiones clínicas.

Nota para la implementación: dado que algunos sistemas de información del nivel primario de atención del departamento utilizan escalas no recomendadas (p. ej., Framingham), se sugiere promover la transición hacia las escalas recomendadas en la actualización 2025 de la Guía de Práctica Clínica para el manejo de la hipertensión arterial del Ministerio de Salud y Protección Social. Como apoyo, las calculadoras de riesgo cardiovascular (SCORE2-PURE, ASCVD y PREVENT) están disponibles en https://www.medicinafamiliaruptc.com/adultez, herramienta desarrollada por la Especialización en Medicina Familiar de la UPTC; su uso debe acompañarse de la verificación técnica y clínica descrita en las recomendaciones anteriores.

9.3 Pautas pregunta 2. Intervenciones

- En toda familia con uno o más integrantes con riesgo cardiovascular, se recomienda formular un plan de intervención multicomponente que combine educación en salud, consejería para el cambio de comportamiento, establecimiento de metas, automonitoreo, seguimiento periódico y acompañamiento del equipo de salud o de agentes comunitarios. No se recomienda limitar el abordaje a la entrega aislada de información.
- El plan familiar debe acordar metas específicas, medibles y factibles, priorizando inicialmente los factores con mayor contribución al riesgo

y aquellos sobre los cuales la familia tenga capacidad real de acción. Las metas deben revisarse y ajustarse durante el seguimiento.

- En personas sin contraindicaciones para realizar ejercicio, se recomienda promover al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o una combinación equivalente con actividad vigorosa, distribuidos durante la semana.

- La actividad aeróbica puede incluir caminar a paso rápido, montar bicicleta, correr u otras actividades adaptadas a las preferencias, capacidad funcional, edad, condiciones clínicas y recursos del entorno. La progresión debe ser gradual cuando la persona sea sedentaria, tenga limitaciones funcionales o presente multimorbilidad.

- Se recomienda complementar la actividad aeróbica con dos a tres sesiones semanales de ejercicios de fuerza, resistencia dinámica, ejercicios interválicos o ejercicios isométricos, como sentadillas isométricas en pared o ejercicios de fuerza de agarre, siempre que sean apropiados para la condición de la persona.

- Si existen síntomas durante el ejercicio, limitaciones funcionales importantes, enfermedad cardiovascular conocida o dudas sobre la seguridad de iniciar actividad vigorosa, se recomienda solicitar valoración clínica antes de intensificar la actividad física. El plan debe adaptarse a las condiciones individuales y no aplicar una misma prescripción a todos los integrantes de la familia.

- Para favorecer la actividad física familiar, se recomienda acordar horarios, acompañamiento y actividades compartidas, identificar espacios seguros y definir alternativas dentro del hogar cuando las condiciones climáticas, territoriales o de seguridad limiten la actividad al aire libre.

- En alimentación, se recomienda promover un patrón familiar cardioprotector basado en mayor consumo de frutas, verduras, granos enteros, proteínas saludables, grasas insaturadas y alimentos mínimamente procesados, acompañado de reducción de sodio, azúcares añadidos y productos ultraprocesados.

- Las orientaciones alimentarias deben traducirse en decisiones concretas del hogar: planeación de compras, selección de alimentos disponibles en el territorio, lectura de etiquetas nutricionales al hacer las compras, cuando sea posible, reducción de sal durante la preparación, sustitución de productos ultraprocesados y organización

de preparaciones familiares saludables. Para ello puede utilizarse la estrategia educativa del plato saludable.

- Si existen sobrepeso u obesidad, se recomienda incorporar el control del peso dentro del plan familiar mediante cambios sostenibles en alimentación, actividad física y rutinas del hogar, evitando recomendaciones aisladas o difíciles de mantener.

- En cada valoración se debe indagar el consumo de tabaco. Si una persona consume productos de tabaco, se recomienda aconsejar el cese total, valorar disposición para abandonar el consumo, ofrecer apoyo conductual y facilitar el acceso a intervención farmacológica o programas especializados cuando esté indicado.

- No se debe recomendar el inicio del consumo de alcohol con fines de protección cardiovascular. Si se identifica consumo alto o episódico, se recomienda acordar metas de reducción o suspensión, explorar su efecto sobre la presión arterial, la toma de medicamentos y las relaciones familiares, y gestionar apoyo adicional cuando sea necesario.

- Las intervenciones sobre alimentación, actividad física, tabaco, alcohol y control de peso deben incorporar consejería, metas, automonitoreo y refuerzo periódico. La evidencia favorece estos paquetes sobre las acciones de un único componente.

- Se recomienda que las metas se registren en términos concretos, por ejemplo: días y minutos de actividad física; número de preparaciones familiares con menor contenido de sal; sustituciones alimentarias acordadas; fecha para iniciar cesación de tabaco; o mecanismo familiar de seguimiento.

- En familias con dificultades para sostener los cambios, se recomienda utilizar entrevistas o consejería motivacional, identificar barreras, reforzar avances pequeños y reformular las metas, en lugar de atribuir el incumplimiento únicamente a falta de voluntad.

- Las visitas domiciliarias y el seguimiento liderado por enfermería o equipos comunitarios deben priorizarse en personas con riesgo cardiovascular elevado, multimorbilidad, dificultades de acceso, baja alfabetización en salud, control clínico insuficiente, baja adherencia o redes de apoyo débiles.

- Cuando exista capacidad territorial, se recomienda complementar las acciones domiciliarias con grupos educativos, actividades comunitarias, redes de apoyo entre pares y movilización comunitaria, especialmente para fortalecer actividad física, alimentación saludable y conocimiento sobre el riesgo cardiovascular.

- En personas con riesgo bajo, se recomienda ofrecer educación estructurada, metas preventivas familiares, orientación sobre estilos de vida y refuerzo periódico, con reevaluación del riesgo según evolución y normativa vigente.

- En personas con riesgo intermedio, se recomienda formular un plan estructurado con metas específicas, automonitoreo, revisión de barreras, seguimiento más frecuente y articulación con los servicios requeridos para controlar presión arterial, peso, glucemia, lípidos y otros factores identificados.

- En personas con riesgo alto, acumulación de múltiples factores o multimorbilidad, se recomienda intensificar el acompañamiento mediante seguimiento cercano, visitas domiciliarias cuando sean pertinentes, intervención interdisciplinaria, revisión del tratamiento farmacológico y articulación oportuna con el nivel primario y la atención especializada.

- La priorización no debe depender únicamente del riesgo clínico. Se recomienda intensificar el apoyo cuando existan pobreza, ruralidad dispersa, inseguridad alimentaria, barreras de transporte, baja alfabetización, discapacidad, ausencia de espacios seguros, violencia, sobrecarga familiar o dificultad para acceder a medicamentos y servicios, dado que estas condiciones reducen la posibilidad de sostener los cambios.

- Para integrar las recomendaciones anteriores, se recomienda utilizar los ocho componentes de Life's Essential 8 (alimentación saludable, actividad física, no exposición al tabaco, sueño adecuado, peso saludable y control del colesterol, la glucemia y la presión arterial) como marco práctico para organizar, comunicar y hacer seguimiento al plan familiar. Los materiales educativos derivados, como infografías adaptadas al territorio, deben usarse como apoyo a la consejería y no como estrategia única.

- Se recomienda promover un sueño de 7 a 9 horas por noche en los adultos, con horarios regulares y medidas de higiene del sueño, como componente del plan familiar de salud cardiovascular.

9.4 Pautas pregunta 3. Escalamiento y coordinación

- En toda familia con integrantes con riesgo cardiovascular se recomienda brindar educación sobre el reconocimiento temprano de los signos y síntomas de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares agudos y sobre la necesidad de solicitar atención urgente. Como aspecto de implementación territorial, el equipo debe informar los mecanismos locales disponibles para activar la atención de urgencias (números de contacto e institución o servicio al que se debe acudir), verificar que la información sea comprensible para los integrantes de la familia y registrarla en el plan de cuidado familiar.

- Se recomienda enseñar a las personas y familias a reconocer los signos neurológicos de aparición súbita compatibles con accidente cerebrovascular mediante una herramienta estructurada de reconocimiento, como CORRE, y verificar su comprensión:

  C (Cara torcida): un lado de la cara se desvía o cae de repente.

  O (Ojo): pérdida repentina de la visión o alteraciones visuales en uno o ambos ojos.

  R (Rápida debilidad): pérdida súbita de fuerza o adormecimiento en un brazo o una pierna.

  R (Raro al hablar): dificultad para hablar, palabras arrastradas o dificultad para entender lo que se dice.

  E (Emergencia): llamar de inmediato a los servicios de urgencias o acudir al hospital, sin esperar a que los síntomas desaparezcan.

- Se recomienda que los equipos del PICF entreguen el acrónimo CORRE mediante un soporte visual permanente en el hogar (por ejemplo, un imán o un afiche), y no únicamente mediante folletos, en el que se anoten los números de emergencia y la institución de referencia más cercana con disponibilidad de tomografía.

- Se recomienda que los profesionales del departamento conozcan y se familiaricen con los lineamientos técnicos, operativos y asistenciales del Código ICTUS de la Secretaría de Salud de Boyacá y, donde esté disponible, con la estrategia de TeleIctus con el fin de activar

oportunamente la ruta ante la sospecha de accidente cerebrovascular (consenso de expertas).

- Si aparece uno o más signos compatibles con accidente cerebrovascular, se recomienda activar inmediatamente el servicio de urgencias o la ruta de referencia disponible. No se debe esperar a que los síntomas desaparezcan ni retrasar la consulta por trámites administrativos o por intentar completar valoraciones no esenciales en el domicilio.

- En el nivel primario o prehospitalario, ante sospecha de accidente cerebrovascular, se recomienda utilizar herramientas estructuradas de reconocimiento como FAST, CPSS, ROSIER o NIHSS, según el perfil del equipo y el escenario de atención. La aplicación de estas herramientas no debe retrasar la remisión ni el traslado.

- Ante sospecha de accidente cerebrovascular se debe minimizar el tiempo entre el inicio de los síntomas, el reconocimiento, la activación de la ruta, el traslado, la neuroimagen y la valoración para reperfusión. La trombólisis intravenosa es altamente dependiente del tiempo y tiene mayor efectividad dentro de las primeras 4,5 horas; la trombectomía puede beneficiar a personas seleccionadas hasta 24 horas después del inicio.

- Cuando sea posible, el equipo que realiza la remisión debe efectuar prenotificación al servicio receptor, con el fin de reducir retrasos y facilitar la preparación para la valoración y el tratamiento oportuno.

- En personas con hipertensión, se recomienda educar sobre la forma correcta de medir la presión arterial, los objetivos definidos por el equipo tratante y la necesidad de consultar cuando existan cifras repetidamente elevadas respecto del objetivo individual o cuando se acompañen de síntomas sugestivos de afectación de órgano.

- Si durante la visita se identifica presión arterial elevada junto con signos neurológicos focales, alteración aguda del estado mental, deterioro cognitivo reciente u otros hallazgos sugestivos de daño agudo de órgano, se debe activar la valoración urgente y la ruta correspondiente. La decisión no debe basarse únicamente en la cifra tensional aislada.

- Cuando la visita sea realizada por personal de salud con competencia clínica, se recomienda realizar una valoración dirigida según el motivo de atención y los recursos disponibles que, en la persona con

hipertensión o sospecha de descompensación, explore signos y síntomas de daño de órgano y de hipertensión secundaria, incluyendo evaluación neurológica y cognitiva, valoración cardiovascular, evaluación vascular periférica y comparación de la presión arterial en ambos brazos. Los hallazgos que sugieran daño agudo de órgano o descompensación deben activar la ruta correspondiente.

- Si se identifican signos neurológicos focales, quejas cognitivas nuevas o antecedente de enfermedad cerebrovascular acompañado de cambios clínicos, se recomienda gestionar evaluación médica prioritaria y neuroimagen cuando corresponda.

- Ante evidencia o sospecha de daño agudo de órgano mediado por hipertensión, la remisión y el inicio del tratamiento clínicamente indicado no deben retrasarse por la espera de estudios complementarios. El manejo debe articularse con el servicio responsable y ajustarse a la condición clínica de la persona; este principio debe reforzarse en la capacitación del personal médico del departamento para prevenir la inercia clínica.

- Se recomienda remitir para valoración por medicina interna u otra especialidad cuando se identifique progresión de daño de órgano, control inadecuado de la presión arterial pese a tratamiento intensivo, comorbilidades no controladas, sospecha de hipertensión secundaria, polifarmacia compleja o interacciones farmacológicas relevantes.

- La evidencia disponible permite recomendar la activación inmediata de la atención de urgencias, sin demoras administrativas, ante sospecha de infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca aguda u otras emergencias cardiovasculares.

- La valoración inicial en el nivel primario debe incluir clasificación del riesgo cardiovascular y metabólico, identificación de factores modificables, interpretación o solicitud de exámenes según los hallazgos y evaluación de condiciones manifiestas como hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad o enfermedad renal crónica; sus hallazgos deben utilizarse no solo para clasificar el riesgo, sino también para decidir oportunamente cuándo escalar la atención.

- Las actividades de valoración o clasificación del riesgo no deben convertirse en barreras para acceder a consultas, pruebas diagnósticas, procedimientos, medicamentos o tratamientos que sean necesarios de acuerdo con los hallazgos clínicos.

- En personas cuyo riesgo pueda estar subestimado por una escala, se recomienda complementar la estimación con juicio clínico y reevaluación periódica, especialmente cuando existan condiciones no capturadas suficientemente por el modelo, progresión clínica o factores sociales que incrementen la vulnerabilidad.

- Si una persona rechaza, aplaza o interrumpe una evaluación o intervención necesaria, se recomienda explorar los motivos, explicar los riesgos y beneficios, respetar su capacidad de decisión y acordar una fecha de reevaluación, siempre que no se encuentre ante una situación de urgencia.

- La ruta de atención debe definir claramente las responsabilidades de la familia, el equipo domiciliario, el nivel primario, los servicios de transporte y el prestador receptor, con el propósito de garantizar continuidad, información clínica suficiente y referencia según la complejidad requerida.

9.5 Pautas pregunta 4. Intervenciones para adherencia

- En toda persona que reciba medicamentos para el manejo del riesgo cardiovascular se recomienda evaluar periódicamente la adherencia, de forma respetuosa y no culpabilizante, durante la visita domiciliaria, la dispensación, el seguimiento y la revisión del tratamiento.

- Para explorar la adherencia, se recomienda formular preguntas concretas y abiertas, por ejemplo, si en la última semana la persona olvidó alguna dosis, redujo la cantidad, suspendió temporalmente, reinició por decisión propia o tomó el medicamento en un horario diferente al acordado. Se debe explicar que estas preguntas buscan identificar apoyos necesarios y no vigilar ni sancionar a la persona.

- Si se identifica no adherencia, se recomienda establecer si es principalmente:
    - Intencional: relacionada con creencias, dudas sobre la necesidad del medicamento, temor a efectos adversos, experiencias previas, preferencias o decisión de minimizar el número de medicamentos.
    - No intencional: relacionada con olvido, dificultades para comprender las indicaciones, problemas de visión, audición o cognición, complejidad de horarios, polifarmacia, costo,

desabastecimiento, barreras de acceso o dificultades para manipular los medicamentos.

- No se recomienda aplicar una intervención uniforme a todas las personas con baja adherencia. El apoyo debe seleccionarse según la barrera concreta identificada y las preferencias, capacidades y condiciones del hogar.

- Se recomienda explorar, según el caso, los factores personales, clínicos, familiares y del sistema de salud que puedan contribuir a la no adherencia, entre ellos: conocimientos sobre la enfermedad y el tratamiento, percepción de necesidad del medicamento, preocupaciones por efectos adversos, síntomas depresivos, autoeficacia, experiencias previas, relación con el equipo de salud, complejidad del régimen, costos, disponibilidad del medicamento, rutinas diarias, alfabetización en salud y apoyo familiar.

- La persona debe participar en las decisiones sobre sus medicamentos. Se recomienda explicar de manera clara el objetivo del tratamiento, los beneficios esperados, los riesgos de no tomarlo, los posibles efectos adversos, la forma de uso, qué hacer ante una dosis olvidada y cómo obtener nuevas prescripciones o suministros.

- Con autorización de la persona, se recomienda involucrar a familiares o cuidadores para apoyar la organización, los recordatorios, el retiro de medicamentos, la asistencia a controles y la identificación de efectos adversos. La familia no debe administrar, modificar ni suspender tratamientos en contra de la voluntad de una persona con capacidad para decidir.

- Se recomienda que la persona y su familia mantengan una lista actualizada de todos los medicamentos utilizados, incluyendo nombre, dosis, horario, indicación, medicamentos sin prescripción, suplementos, productos herbales, alergias y reacciones adversas conocidas.

- Durante la educación sobre medicamentos se recomienda utilizar el método de enseñanza con verificación de comprensión o teach-back. Después de explicar, se debe pedir a la persona que describa con sus propias palabras para qué sirve cada medicamento, cómo lo tomará y qué hará ante un problema. Cuando se identifiquen errores o vacíos de comprensión, se debe repetir la explicación y verificar nuevamente.

- La educación debe adaptarse a las necesidades de la persona mediante lenguaje sencillo, ejemplos prácticos, pictogramas, letras grandes, códigos de color, materiales en el idioma apropiado o participación de un intérprete o persona de apoyo cuando sea necesario.

- No se recomienda utilizar la entrega de folletos o instrucciones escritas como única estrategia educativa. La información debe discutirse, verificarse y reforzarse en el tiempo.

- Cuando la complejidad del régimen contribuya a la no adherencia, se recomienda solicitar al prescriptor o al profesional responsable una revisión para simplificar la frecuencia de las dosis, ajustar horarios o valorar alternativas terapéuticas apropiadas. La persona o la familia no deben modificar por cuenta propia la dosis ni suspender medicamentos.

- Si se identifica olvido o dificultad para organizar la toma, se pueden recomendar herramientas prácticas como pastilleros, blísteres calendario, sistemas multicompartimento, calendarios, registros de toma, alarmas o asociación del medicamento con una rutina cotidiana. Los pastilleros y empaques recordatorios pueden considerarse especialmente en personas con múltiples medicamentos, horarios complejos o baja alfabetización. Estas herramientas deben utilizarse solo cuando respondan a una necesidad concreta, exista revisión previa del tratamiento y la persona pueda manejarlas de forma segura, sin generar confusión o errores. Se recomienda, además, desarrollar herramientas visuales que sirvan como alarma o estrategia de recordación.

- Si la persona experimenta efectos adversos o tiene temor de presentarlos, se recomienda explorar su naturaleza y repercusión, explicar las alternativas disponibles y gestionar revisión por el prescriptor. Los cambios de dosis, horario o medicamento deben realizarse por el profesional autorizado y no por la familia.

- Si los costos, la falta de disponibilidad, el transporte o las dificultades de autorización impiden la toma, se recomienda activar las gestiones institucionales necesarias para asegurar continuidad del suministro. Estas situaciones deben registrarse como barreras del sistema y no interpretarse como falta de compromiso de la persona.
- Las intervenciones lideradas por enfermería, farmacia u otros profesionales pueden incluir educación adaptada, entrevista motivacional, revisión del uso de medicamentos, seguimiento telefónico y visitas presenciales. Se recomienda privilegiar modelos

presenciales o mixtos cuando la persona tiene mayor riesgo, múltiples medicamentos, baja adherencia persistente o dificultades de comprensión.

- Las intervenciones deben integrar, cuando sea pertinente, educación, simplificación, recordatorios, seguimiento, retroalimentación y apoyo familiar. Las estrategias multicomponente e individualizadas muestran mejores perspectivas que las intervenciones aisladas, aunque sus efectos pueden ser modestos y variables.

- Las herramientas digitales –mensajes de texto, aplicaciones, telemonitoreo, alarmas electrónicas o plataformas de telesalud– pueden utilizarse como apoyo complementario cuando la persona y su familia tengan acceso, capacidad y disposición para utilizarlas.

- No se recomienda utilizar mensajes de texto o aplicaciones como única respuesta ante la no adherencia. Las herramientas digitales parecen más útiles cuando se combinan con educación, automonitoreo, retroalimentación y posibilidad de contacto con el equipo de salud.

- Cuando se utilicen tecnologías digitales, se recomienda que sean simples, personalizables, comprensibles, sostenibles y adaptadas a los horarios y medicamentos de la persona. Se debe evitar la sobrecarga de mensajes, la repetición excesiva y los contenidos que puedan percibirse como paternalistas o culpabilizantes.

- Antes de recomendar una aplicación o dispositivo, se debe valorar alfabetización digital, conectividad, costo, accesibilidad para personas mayores o con discapacidad, confiabilidad técnica, privacidad y control sobre los datos personales.

- Si se dispone de información objetiva sobre dispensación, registros de toma o monitoreo, esta debe utilizarse para promover una conversación comprensiva y resolver problemas, no para confrontar o sancionar a la persona. La retroalimentación debe ser clara, no juzgadora y orientada a decisiones compartidas.

- En personas con baja motivación, dudas sobre la necesidad del tratamiento o percepciones negativas, se recomienda utilizar consejería motivacional, explorar ventajas y desventajas percibidas, reforzar la autoeficacia y acordar metas graduales.

- En personas con depresión, deterioro cognitivo, baja alfabetización, discapacidad, aislamiento o apoyo familiar insuficiente, se recomienda

intensificar el acompañamiento e involucrar, con consentimiento, a familiares, cuidadores y profesionales requeridos.

- Después de implementar una estrategia de apoyo se debe acordar una fecha de seguimiento y valorar si mejoró la toma del medicamento, si persisten barreras y si hubo cambios en desenlaces clínicos como presión arterial, glucemia o lípidos. Si no existe mejoría, se debe reformular el plan e intensificar el apoyo.

- La adherencia debe entenderse como un proceso dinámico. Se recomienda revisar periódicamente la comprensión, las preocupaciones, las preferencias, la experiencia con los efectos adversos, la capacidad para sostener las rutinas y las necesidades de apoyo, especialmente en tratamientos prolongados o con múltiples medicamentos.

- En ningún caso la no adherencia debe presentarse como responsabilidad exclusiva o falla moral de la persona. El equipo debe reconocer las barreras clínicas, familiares y del sistema, preservar la autonomía y construir soluciones conjuntamente con la persona y su familia.

- Como parte de las estrategias educativas, se recomienda enseñar a la persona y su familia el almacenamiento y la conservación adecuados de los medicamentos en el hogar: protegerlos de la luz, el calor y la humedad, mantenerlos en su empaque original, fuera del alcance de niñas y niños, y revisar periódicamente las fechas de vencimiento (consenso de expertas).

10. Referencias

1. Secretaria de salud de Boyacá. Análisis de la sitación de salud de la vigencia 2023. ASIS Boyacá 2023. Tunja; 2024.
2. Secretaria de Salud de Boyacá. Análisis de la situación de salud de la vigencia 2024. ASIS Boyacá 2024. Tunja; 2025.
3. Secretaria de Salud de Boyacá. Informe trimestral de indicadores SIBACOM. Tunja; 2025 Jul.
4. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3280. Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la

Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las dir. ectrices para su operación. Bogotá, Colombia.; 2018.

5. World Health Organization. Know your cardiovascular disease risk. Take Action. 2019.

6. Di Castelnuovo A, Quacquaruccio G, Donati MB, de Gaetano G, Iacoviello L. Spousal Concordance for Major Coronary Risk Factors: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Epidemiol. 2008 Oct 8;169(1):1–8. doi:10.1093/aje/kwn234

7. Bischops AC, De Neve JW, Awasthi A, Vollmer S, Bärnighausen T, Geldsetzer P. A cross-sectional study of cardiovascular disease risk clustering at different socio-geographic levels in India. Nat Commun. 2020 Nov 18;11(1):5891. doi:10.1038/s41467-020-19647-3

8. van Egeraat JWA, van Geloven N, Hageman SHJ, Bonten TN, Cahn W, Vos RC, et al. External validation of the SMART2 model for recurrent cardiovascular risk: performance in socioeconomic, ethnic and psychiatric subgroups. Open Heart. 2026 Jan 16;13(1):e003882. doi:10.1136/openhrt-2025-003882

9. Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Consenso colombiano para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias en adultos. Rev Colomb Cardiol. 2024 Dec 5;31(Supl4):3–86.

10. Hernández JA, Dulcey-Sarmiento L, Gómez- Ayala J, Therán -León J, Toscano-Dulcey L. Evaluación del riesgo cardiovascular mediante la escala prevent en adultos mayores del noroccidente de colombia, 2014-2024. Archivos de Medicina (Manizales). 2025 Sep 25;26(1). doi:10.30554/archmed.26.1.5448.2026

11. Abdul Jabbar A Bin, Inam M, Butt N, Khan SS, Sheikh S, Khoja A, et al. Predicting Risk of Cardiovascular Disease EVENTs (PREVENT) Equations: What Clinicians Need to Know? Curr Atheroscler Rep. 2025 Dec 21;27(1):73. doi:10.1007/s11883-025-01320-z

12. Ministerio de Salud y Protección Social. Actualización parcial de la Guía de Práctica Clínica para el manejo de la hipertensión arterial (HTA) Guía completa. 2025.

13. Ndejjo R, Hassen HY, Wanyenze RK, Musoke D, Nuwaha F, Abrams S, et al. Community-Based Interventions for Cardiovascular Disease Prevention in Low-and Middle-Income Countries: A Systematic Review. Public Health Reviews. Frontiers Media S.A.; 2021. doi:10.3389/phrs.2021.1604018

14. Tan SM, Han E, Quek RYC, Singh SR, Gea-Sánchez M, Legido-Quigley H. A systematic review of community nursing interventions focusing on improving outcomes for individuals exhibiting risk factors of cardiovascular disease. Journal of Advanced Nursing. Blackwell Publishing Ltd; 2020. p. 47–61. doi:10.1111/jan.14218 PubMed PMID: 31588578.

15. Frith M, Angeles MR, Savira F, Randall S, Lee CMY, Huxley R, et al. Community based interventions for the primary prevention of cardiovascular disease in women living in rural, regional and remote areas: a scoping review. BMC Health Serv Res. 2026 Dec 1;26(1). doi:10.1186/s12913-026-14192-z PubMed PMID: 41703569.

16. Khan SS, Bhave N, Blumenthal RS, Coresh J, Huang X, Joseph JJ, et al. Use of Predicted Risk and Expected Benefit to Guide Decision-Making in Cardiovascular-Kidney-Metabolic Syndrome for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation. 2026 Jun 9. doi:10.1161/CIR.0000000000001447

17. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberger ZD, Hahn EJ, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. NLM (Medline); 2019. p. e596–646. doi:10.1161/CIR.0000000000000678 PubMed PMID: 30879355.

18. Piano MR, Marcus GM, Aycock DM, Buckman J, Hwang CL, Larsson SC, et al. Alcohol Use and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation. 2025 Jul 8;152(1):e7–21. doi:10.1161/CIR.0000000000001341 PubMed PMID: 40485439.

19. Lloyd-Jones DM, Allen NB, Anderson CAM, Black T, Brewer LC, Foraker RE, et al. Life's Essential 8: Updating and Enhancing the American Heart Association's Construct of Cardiovascular Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2022 Aug 2;146(5). doi:10.1161/CIR.0000000000001078

20. Almunif TM, Alkaabba AF, Alomran KW, Alanazi AM, Alharbi FN, Alshahrani SS, et al. Early Recognition and Referral of Acute Stroke in Primary and Emergency Care: A Systematic Review. West J Emerg Med. 2026 Jan 24;27(3):804–18. doi:10.5811/westjem.50827 PubMed PMID: 42258866.

21. Abbasian M, Rashidi Birgani H, Khabiri R, Namvar L, Jahangiry L. Exploring Education Interventions for Stroke Prevention Among Adults and Older Individuals: A Scoping Review. Health Science Reports. John Wiley and Sons Inc; 2024. doi:10.1002/hsr2.70167

22. Moriel-Galarza KP, Nava-González EJ, Mejia-Mejia Y, Micaela E, García Á. Prevención del riesgo cardiovascular mediante la alfabetización en salud: Revisión de la literatura [Internet]. Available from: https://orcid.org/0000-0003-4813-9653

23. Ministerio de Salud y Protección Social. LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD PARA PERSONAS CON RIESGO O PRESENCIA DE ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR-METABOLICAS MANIFIESTAS. 2018.

24. Institute for Health N, Excellence C. Cardiovascular disease: risk assessment and reduction, including lipid modification NICE guideline [Internet]. 2023. Available from: www.nice.org.uk/guidance/ng238

25. Nieuwlaat R, Wilczynski N, Navarro T, Hobson N, Jeffery R, Keepanasseril A, et al. Interventions for enhancing medication adherence. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2014. doi:10.1002/14651858.CD000011.pub4 PubMed PMID: 25412402.

26. Anderson LJ, Nuckols TK, Coles C, Le MM, Schnipper JL, Shane R, et al. A systematic overview of systematic reviews evaluating medication adherence interventions. American Journal of Health-System Pharmacy. 2020 Jan 1;77(2):138–47. doi:10.1093/ajhp/zxz284 PubMed PMID: 31901098.

27. Schroeder K, Fahey T, Ebrahim S. Interventions for improving adherence to treatment in patients with high blood pressure in ambulatory settings. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2004. doi:10.1002/14651858.CD004804 PubMed PMID: 15106262.

28. van Driel ML, Morledge MD, Ulep R, Shaffer JP, Davies P, Deichmann R. Interventions to improve adherence to lipid-lowering medication. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2016. doi:10.1002/14651858.CD004371.pub4 PubMed PMID: 28000212.

29. Kengne AP, Brière JB, Gudiña IA, Jiang X, Kodjamanova P, Bennetts L, et al. The impact of non-pharmacological interventions on adherence to medication and persistence in dyslipidaemia and hypertension: a systematic review. Expert Review of

Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Taylor and Francis Ltd.; 2024. p. 807–16. doi:10.1080/14737167.2024.2319598 PubMed PMID: 38366854.

30. Berardinelli D, Conti A, Hasnaoui A, Casabona E, Martin B, Campagna S, et al. Nurse-Led Interventions for Improving Medication Adherence in Chronic Diseases: A Systematic Review. Healthcare (Switzerland). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI); 2024. doi:10.3390/healthcare12232337

31. El Hussein MT, Dhaliwal S. Enhancing adherence: Evaluating interventions for Heart Failure management in older adults. Geriatr Nurs (Minneap). 2026 Mar 1;68. doi:10.1016/j.gerinurse.2025.103779 PubMed PMID: 41468839.

32. Mahtani KR, Heneghan CJ, Glasziou PP, Perera R. Reminder packaging for improving adherence to self-administered long-term medications. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011 Sep 7. doi:10.1002/14651858.cd005025.pub3 PubMed PMID: 21901694.

33. Cadel L, Cimino SR, Bradley-Ridout G, Hitzig SL, Patel T, Ho CH, et al. Medication self-management interventions for persons with stroke: A scoping review. PLoS One. 2023 May 1;18(5 May). doi:10.1371/journal.pone.0285483 PubMed PMID: 37200316.

34. Alipanah N, Jarlsberg L, Miller C, Linh NN, Falzon D, Jaramillo E, et al. Adherence interventions and outcomes of tuberculosis treatment: A systematic review and meta-analysis of trials and observational studies. PLoS Med. 2018 Jul 1;15(7). doi:10.1371/journal.pmed.1002595 PubMed PMID: 29969463.

35. Bingham JM, Black M, Anderson EJ, Li Y, Toselli N, Fox S, et al. Impact of Telehealth Interventions on Medication Adherence for Patients With Type 2 Diabetes, Hypertension, and/or Dyslipidemia: A Systematic Review. Annals of Pharmacotherapy. SAGE Publications Inc.; 2021. p. 637–49. doi:10.1177/1060028020950726 PubMed PMID: 32815400.

36. Palmer MJ, Barnard S, Perel P, Free C. Mobile phone-based interventions for improving adherence to medication prescribed for the primary prevention of cardiovascular disease in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2018. doi:10.1002/14651858.CD012675.pub2 PubMed PMID: 29932455.

37. Chun-Yun Kang G. Technology-based interventions to improve adherence to antihypertensive medications – An evidence-based

review. Digital Health. SAGE Publications Inc.; 2022. doi:10.1177/20552076221089725

38. Belete AM, Gemeda BN, Akalu TY, Aynalem YA, Shiferaw WS. What is the effect of mobile phone text message reminders on medication adherence among adult type 2 diabetes mellitus patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Endocr Disord. 2023 Dec 1;23(1). doi:10.1186/s12902-023-01268-8 PubMed PMID: 36658577.

39. Palmer MJ, Machiyama K, Woodd S, Gubijev A, Barnard S, Russell S, et al. Mobile phone-based interventions for improving adherence to medication prescribed for the primary prevention of cardiovascular disease in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2021 Mar 26;2021(3). doi:10.1002/14651858.CD012675.pub3 PubMed PMID: 33769555.

40. Redfern J, Tu Q, Hyun K, Hollings MA, Hafiz N, Zwack C, et al. Mobile phone text messaging for medication adherence in secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2024. doi:10.1002/14651858.CD011851.pub3 PubMed PMID: 38533994.

41. Sua YS, Jiang Y, Thompson DR, Wang W. Effectiveness of mobile phone-based self-management interventions for medication adherence and change in blood pressure in patients with coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Cardiovascular Nursing. SAGE Publications Inc.; 2020. p. 192–200. doi:10.1177/1474515119895678 PubMed PMID: 31856596.

42. Enricho Nkhoma D, Jenya Soko C, Joseph Banda K, Greenfield D, Li YC, Iqbal U. Impact of DSMES app interventions on medication adherence in type 2 diabetes mellitus: Systematic review and meta-analysis. BMJ Health and Care Informatics. BMJ Publishing Group; 2021. doi:10.1136/bmjhci-2020-100291 PubMed PMID: 33853862.

43. Archer M, Llahana S. Understanding factors influencing medication adherence in Type 2 diabetes guided by the COM-B behaviour change model and assessed using the Morisky scale: A systematic review. Prim Care Diabetes. 2026 Apr. doi:10.1016/j.pcd.2026.01.002 PubMed PMID: 41535138.

44. Institute for Health N, Excellence C. Medicines adherence: involving patients in decisions about prescribed medicines and supporting adherence Clinical guideline [Internet]. 2009. Available from: www.nice.org.uk/guidance/cg76

45. Institute for Health N, Excellence C. Medicines adherence: involving patients in decisions about prescribed medicines and supporting adherence Clinical guideline [Internet]. 2009. Available from: www.nice.org.uk/guidance/cg76

46. Ha Dinh TT, Bonner A, Clark R, Ramsbotham J, Hines S. The effectiveness of the teach-back method on adherence and self-management in health education for people with chronic disease: a systematic review. JBI database of systematic reviews and implementation reports. 2016. p. 210–47. doi:10.11124/jbisrir-2016-2296 PubMed PMID: 26878928.

47. Kobson B, Hanley J, Mair A, Dima AL, Rea N, Paterson RE. Patients' perspectives on medication adherence feedback interventions for managing long-term medications: a systematic review of qualitative evidence. International Journal of Clinical Pharmacy. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH; 2025. doi:10.1007/s11096-025-01958-4

11. Anexos

11.1 Ecuaciones de búsqueda

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD	Términos clave	Ecuación de búsqueda
En adultos atendidos en el hogar o en atención primaria/comunitaria, ¿qué escalas o herramientas de riesgo cardiovascular muestran mejor desempeño y factibilidad para clasificar el riesgo y orientar decisiones de cuidado?	Evaluación / clasificación de riesgo	PIT o PIRD: P: población I / index model: instrumento o escala R: riesgo cardiovascular D: desempeño del modelo / capacidad predictiva P (Población): Personas adultas y/o familias abordadas en el entorno hogar en el marco del PICF, sin diagnóstico cardiovascular previo confirmado o con necesidad de valoración de riesgo cardiovascular. I (Intervención / índice): Estrategias e instrumentos de identificación y estratificación del riesgo cardiovascular aplicables en el hogar o en atención primaria/comunitaria, tales como escalas, puntajes,	cardiovascular risk, cardiovascular diseases, family risk, risk assessment, risk stratification, screening, primary health care, home care, household, hypertension, diabetes, obesity, dyslipidemia, smoking, family history	("Cardiovascular Diseases" OR "cardiovascular risk" OR "cardiovascular disease risk" OR hypertension OR diabetes OR dyslipidemia OR obesity OR smoking) AND (family OR household OR home OR "entorno hogar") AND ("Primary Health Care" OR "primary care" OR "atención primaria" OR "nivel primario") AND ("Risk Assessment" OR screening OR stratification OR "risk score" OR "family history" OR "cardiovascular risk assessment") AND (guideline* OR "practice guideline" OR "systematic review" OR consensus)

		algoritmos, listas de chequeo, tamizajes clínicos o combinaciones de factores de riesgo. C (Comparador): Ausencia de instrumento estructurado Juicio clínico no estandarizado Otro instrumento o estrategia de estratificación de riesgo cardiovascular O (Desenlaces): Capacidad para identificar personas o familias con riesgo cardiovascular aumentado Validez diagnóstica o predictiva del instrumento Discriminación y calibración, cuando aplique Sensibilidad, especificidad, valores predictivos o capacidad de clasificación Factibilidad de uso en entorno hogar o atención primaria Utilidad para orientar compromisos de cuidado, seguimiento, remisión o activación de rutas		

En personas adultas y familias con riesgo cardiovascular abordadas en el entorno hogar, ¿qué intervenciones familiares o domiciliarias son efectivas y factibles para reducir el riesgo cardiovascular y controlar sus factores de riesgo, y cómo deben priorizarse según el nivel de riesgo cardiovascular?	Intervención / efectividad / factibilidad	P: Personas adultas y/o familias con riesgo cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular en el entorno hogar I: Intervenciones familiares o domiciliarias de prevención y control del riesgo cardiovascular C: Atención habitual, no intervención, intervención mínima u otras intervenciones O: Reducción del riesgo cardiovascular global, control de factores de riesgo, adherencia, factibilidad, aceptabilidad e implementación según nivel de riesgo	family-based intervention, home-based intervention, cardiovascular prevention, lifestyle modification, hypertension control, physical activity, diet, smoking cessation, medication adherence, feasibility, implementation	("Cardiovascular Diseases" OR "cardiovascular risk" OR hypertension OR diabetes OR dyslipidemia OR obesity) AND (family-based OR family OR household OR home OR "entorno hogar") AND (intervention* OR program* OR counseling OR education OR "lifestyle modification" OR diet OR exercise OR "physical activity" OR "smoking cessation" OR "medication adherence") AND (effectiveness OR efficacy OR feasibility OR implementation OR prioritization) AND (guideline* OR "systematic review" OR meta-analysis OR consensus)
En familias con miembros que tienen riesgo cardiovascular o sospecha de descompensación cardiovascular, atendidas en el hogar o en el nivel primario, ¿qué criterios clínicos, signos de alarma	Detección / seguridad / referencia Subpregunta A. Identificación de alarma ¿Qué signos,	P: Adultos con riesgo cardiovascular o síntomas/condiciones sugestivas de evento cardiovascular en hogar, APS o comunidad I: Criterios de alarma, signos de alerta, algoritmos de triage o	follow-up, monitoring, adherence, continuity of care, home visits, family support, self-management, cardiovascular prevention, goal attainment, care coordination	Pubmed: ("Cardiovascular Diseases"[Mesh] OR "Acute Coronary Syndrome"[Mesh] OR "Myocardial Infarction"[Mesh] OR "Stroke"[Mesh] OR "Heart

y hallazgos iniciales permiten activar rutas de atención, remisión o referencia oportuna para prevenir eventos cardiovasculares mayores y garantizar oportunidad diagnóstica y terapéutica?	síntomas o hallazgos iniciales deben considerarse criterios de alarma desde el hogar o el nivel primario? Subpregunta B. Respuesta o activación de rutas ¿Qué acciones de remisión, referencia o activación de rutas deben realizarse ante esos criterios para disminuir retrasos y prevenir eventos mayores?	referencia C: Atención habitual o ausencia de protocolos estructurados O: Activación de rutas, remisión oportuna, oportunidad diagnóstica/terapéutica, prevención de eventos cardiovasculares mayores		Failure"[Mesh] OR "Hypertensive Emergencies"[Mesh] OR "cardiovascular risk"[tiab] OR "major adverse cardiovascular events"[tiab] OR "acute coronary syndrome"[tiab] OR "myocardial infarction"[tiab] OR stroke[tiab] OR "transient ischemic attack"[tiab] OR "heart failure"[tiab] OR "hypertensive emergency"[tiab] OR "hypertensive crisis"[tiab] OR "chest pain"[tiab] OR dyspnea[tiab]) AND ("Signs and Symptoms"[tiab] OR "warning signs"[tiab] OR "alarm signs"[tiab] OR "red flags"[tiab] OR "clinical criteria"[tiab] OR "early signs"[tiab] OR "symptom

				assessment"[tiab] OR triage[tiab] OR "referral criteria"[tiab] OR "clinical deterioration"[tiab]) AND ("Primary Health Care"[Mesh] OR "Home Care Services"[Mesh] OR "Community Health Services"[Mesh] OR home[tiab] OR household[tiab] OR domiciliary[tiab] OR "primary care"[tiab] OR "primary health care"[tiab] OR community[tiab] OR ambulatory[tiab]) AND (referral[tiab] OR "care pathway"[tiab] OR "clinical pathway"[tiab] OR "patient transfer"[tiab] OR "escalation of

				care"[tiab] OR "emergency care"[tiab] OR "urgent care"[tiab] OR "early diagnosis"[tiab] OR "timely diagnosis"[tiab] OR "timely treatment"[tiab] OR "treatment delay"[tiab])
¿Qué estrategias en el entorno hogar deben recomendarse para favorecer la adherencia farmacológica en personas adultas con riesgo cardiovascular y sus familias?		P: Adultos con riesgo cardiovascular o factores de riesgo en tratamiento farmacológico I: Estrategias domiciliarias o familiares para mejorar adherencia C: Atención habitual, no intervención u otras estrategias O: Adherencia, persistencia, continuidad terapéutica y control clínico	PubMed: ("Cardiovascular Diseases/prevention and control"[Mesh] OR "Risk Factors"[Mesh] OR "Hypertension/drug therapy"[Mesh] OR "Diabetes Mellitus/drug therapy"[Mesh] OR "Dyslipidemias/drug therapy"[Mesh] OR "Heart Failure/drug therapy"[Mesh] OR "Kidney Diseases/drug therapy"[Mesh] OR "cardiovascular	PubMed: ("Cardiovascular Diseases/prevention and control"[Mesh] OR "Risk Factors"[Mesh] OR "Hypertension/drug therapy"[Mesh] OR "Diabetes Mellitus/drug therapy"[Mesh] OR "Dyslipidemias/drug therapy"[Mesh] OR "Heart Failure/drug therapy"[Mesh] OR "Kidney Diseases/drug therapy"[Mesh] OR "cardiovascular risk"[tiab] OR "cardiovascular risk

			risk"[tiab] OR "cardiovascular risk factors"[tiab] OR hypertension[tiab] OR diabetes[tiab] OR dyslipidemia[tiab] OR "coronary disease"[tiab] OR "heart failure"[tiab] OR "chronic kidney disease"[tiab]) AND ("Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "medication adherence"[tiab] OR "medication compliance"[tiab] OR "treatment adherence"[tiab] OR "drug adherence"[tiab] OR "medication persistence"[tiab] OR persistence[tiab] OR concordance[tiab] OR "continuity of treatment"[tiab]) AND	factors"[tiab] OR hypertension[tiab] OR diabetes[tiab] OR dyslipidemia[tiab] OR "coronary disease"[tiab] OR "heart failure"[tiab] OR "chronic kidney disease"[tiab]) AND ("Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "medication adherence"[tiab] OR "medication compliance"[tiab] OR "treatment adherence"[tiab] OR "drug adherence"[tiab] OR "medication persistence"[tiab] OR persistence[tiab] OR concordance[tiab] OR "continuity of treatment"[tiab]) AND ("Home Care Services"[Mesh]

			("Home Care Services"[Mesh] OR "Family"[Mesh] OR "Caregivers"[Mesh] OR "Self-Management"[Mesh] OR home-based[tiab] OR household[tiab] OR family-based[tiab] OR "family support"[tiab] OR "caregiver support"[tiab] OR domiciliary[tiab] OR "home visit*"[tiab] OR "self-management support"[tiab] OR "medication management"[tiab] OR reminder*[tiab] OR "pill box"[tiab] OR "medication organizer"[tiab] OR telemonitoring[tiab] OR telehealth[tiab] OR "telephone follow-up"[tiab] OR "text messag*"[tiab]) AND	OR "Family"[Mesh] OR "Caregivers"[Mesh] OR "Self-Management"[Mesh] OR home-based[tiab] OR household[tiab] OR family-based[tiab] OR "family support"[tiab] OR "caregiver support"[tiab] OR domiciliary[tiab] OR "home visit*"[tiab] OR "self-management support"[tiab] OR "medication management"[tiab] OR reminder*[tiab] OR "pill box"[tiab] OR "medication organizer"[tiab] OR telemonitoring[tiab] OR telehealth[tiab] OR "telephone follow-up"[tiab] OR "text messag*"[tiab]) AND (adult[MeSH] OR adult*[tiab]) NOT

			(adult[MeSH] OR adult*[tiab]) NOT (pediatr*[tiab] OR child*[tiab] OR adolescent*[tiab])	(pediatr*[tiab] OR child*[tiab] OR adolescent*[tiab])